



Презентация занятия по теме № 14

Организация работы детских медицинских организаций. Уход за новорожденными и детьми грудного возраста. Особенности воспитания и ухода за детьми старше года. Меры по стимуляции психомоторного развития.

Рождение.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 1687н



- ▶ **Моментом рождения** ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов.
- ▶ Медицинскими **критериями рождения** являются:
 1. срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела ребенка при рождении 25 см и более;
 2. срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка при рождении менее 25 см - при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток).
- ▶ **Живорождением** является момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента).
- ▶ **Мертворождением** является момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при отсутствии у новорожденного признаков живорождения.

Критерии живорожденности (достаточно одного!)

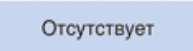
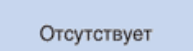
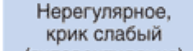
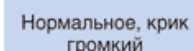


- ▶ Один самостоятельный вдох
- ▶ Сердцебиение
- ▶ Двигательная активность
- ▶ Пульсация пуповины



<http://detkineposed.ru/>

Оценка на 1 и 5 минутах
Нормальные значения – 8 – 10 баллов
Большое значение – динамика к 5-ой минуте

Таблица для оценки новорожденного по шкале Апгар				
Признаки	Баллы	0 баллов	1 балл	2 балла
A – appearance Внешний вид (цвет кожных покровов)				
		Генерализованная бледность или генерализованный цианоз	Розовая окраска тела и синюшная окраска конечностей (акроцианоз)	Розовая окраска всего тела и конечностей
P – pulse Пульс (ЧСС за 1 минуту)				
		Отсутствует	< 100	> 100
G – grimace response Мимический ответ (рефлексы и раздражительность)				
		Не реагирует	Реакция слабо выражена (grimаса, движение)	Реакция в виде движения, кашля, чиханья, громкого крика
A – activity Активность и мышечный тонус				
		Отсутствуют, конечности свисают	Снижены, некоторое сгибание конечностей	Выражены активные движения
R – respiration Дыхание				
		Отсутствует	Нерегулярное, крик слабый (гиповентиляция)	Нормальное, крик громкий

Масса тела при рождении



- ▶ Норма – 2500 – 3500 г
- ▶ Низкая масса тела (НМТ) – до 2500 г
- ▶ Очень низкая масса тела (ОНМТ) – до 1500 г
- ▶ Экстремально низкая масса тела (ЭНМТ) – до 1000 г



Доношенный ребенок

Критерии



- Роды при сроке беременности 259-293 дня (37 полных недель – 42 недели беременности)
- Длина – 50 см
- Масса – 2500-3500 г
- Соотношение длины головы и длины тела 1 : 4
- Ногти ороговевшие, выступают за кончики пальцев
- Длина волос на голове – около 1 см, развиты брови и ресницы
- Кости черепа – твердые, хрящи носа и ушных раковин – плотные
- Яички опущены в мошонку, большие половые губы прикрывают малые
- Подкожная жировая клетчатка развита хорошо, поэтому кожа – розовая, эластичная



Недоношенный ребенок



- ▶ Недоношенность – роды при сроке беременности менее 259 суток (155-259 суток)
- ▶ Длина плода – 25-45 см
- ▶ Масса тела – 500 - 2499 г
- ▶ Соотношение длины головки и длины тела – 1:3
- ▶ Нижние конечности – короткие
- ▶ Кожа – красная, покрыта сыровидной смазкой и пушковыми волосами (lanugo)
- ▶ Мягкость ушных раковин и костей черепа
- ▶ Ногти на пальцах – мягкие, не доходят до конца пальцев
- ▶ Яички не опущены в мошонку, большие половые губы не прикрывают полностью малые половые губы
- ▶ Ядро окостенения Беклара в дистальной части бедра отсутствует (диаметр в норме – 5-7 мм)



Переношенный ребенок



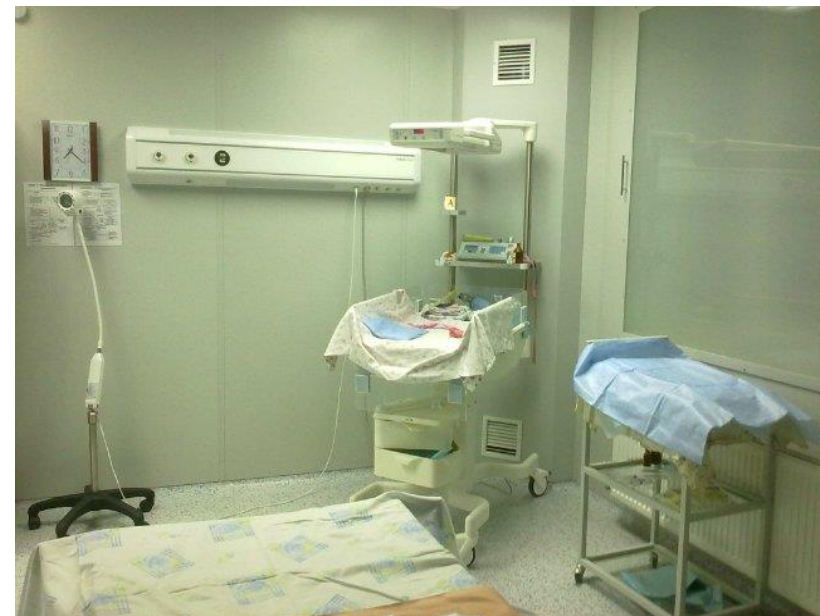
- ▶ Роды при сроке беременности 294 дня и более
- ▶ Сухость, шелушение и частичная мацерация кожи
- ▶ Появление ядра окостенения в большеберцовых и плечевых костях (в норме – нет)
- ▶ Околоплодные воды, пуповина и плацента окрашены меконием
- ▶ Обычно маловодие



Первичный туалет новорожденного. Оборудование



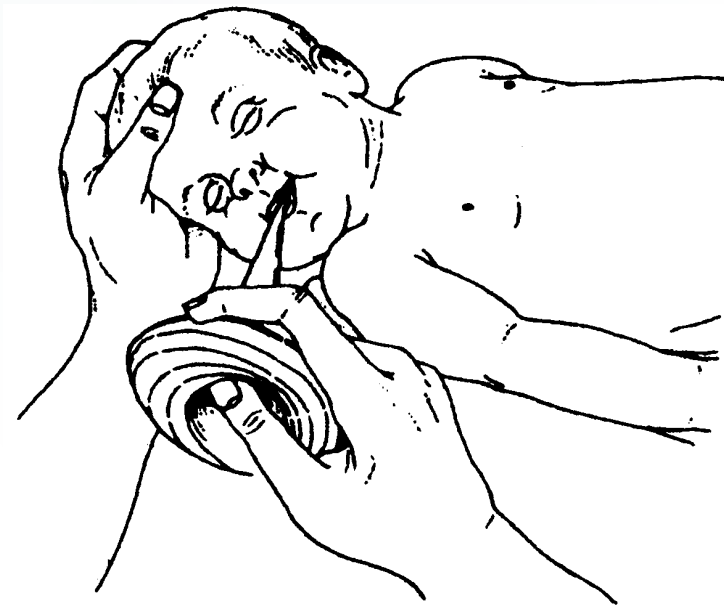
1. индивидуальные комплекты стерильного белья и оборудования (обеззараженный лоток для приема новорожденного; одеяло, 3 бязевых или 3 бумажных пеленок, сантиметровая лента);
2. индивидуальные стерильные комплекты для первичной обработки новорожденного (2 зажима Кохера, скобки Роговина и щипцы для их наложения, шелковая лигатура, марлевая салфетка сложенная в 4 слоя);
3. электроотсос или стерильная груша;
4. антисептик – 70% этиловый спирт;
5. марлевые салфетки, ватные шарики, ватные палочки;
6. стерильное вазелиновое масло 30 мл;
7. 20% сульфацил натрия или 2% нитрат серебра;
8. комплект (браслетики и карточка) для идентификации пациента.



Первичный туалет новорожденного



- ▶ Рекомендуется проводить по показаниям
- ▶ В момент рождения головки ребенка медицинская сестра (акушерка) с целью **профилактики аспирации** проводит отсасывание содержимое из ротовой полости и верхней части глотки с помощью электроотсоса или стерильной резиновой груши
- ▶ Санация из носовых ходов не проводится с целью профилактики рефлекторного вдоха и аспирации содержимого ротовой полости



Первичная обработка здорового новорожденного



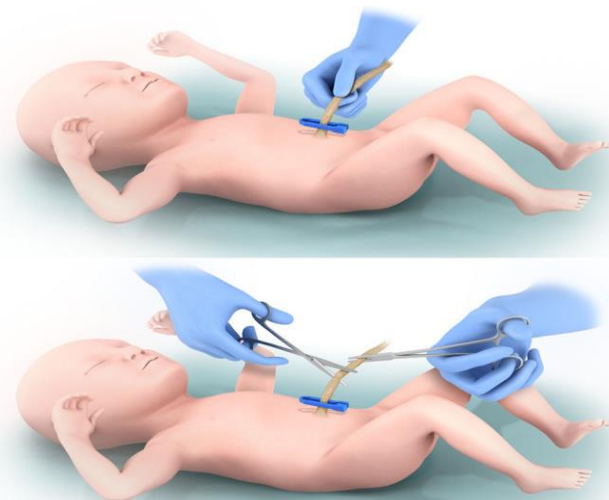
- ▶ Акушерка приняв родившегося обтирает его сухой подогретой стерильной пелёнкой (перед рождением ребенка размещает пеленки на животе матери)
- ▶ Выложить ребенка на живот матери, обеспечивая непрерывный кожный и зрительный контакт на срок 10 от минут до 2-х часов (если позволяет состояние матери и ребенка)
- ❑ Накрыть новорожденного ребенка сухой подогретой стерильной пелёнкой (при необходимости проводится повторное обсушивание кожи новорожденного). Надеть шапочку и носочки. Все эти мероприятия должны быть проведены в первые 40-60 секунд.
- ❑ Накрыть ребенка подогретым стерильным хлопчатобумажным одеялом.
- ❑ Через 1-3 минуты (при стабильном состоянии ребенка) после рождения пересечь пуповину
- ▶ Пережатие пуповины в течение первых нескольких секунд после рождения выполняют
- ❑ При внутриутробно диагностированном Резус-конфликте
- ❑ При ВИЧ-инфекции у матери.
- ▶ В этом случае нужно произвести отжатие пуповинной крови от ребенка к матери.
- ❑ Когда требуются реанимационные мероприятия.



Пережатие и пересечение пуповины



- ▶ Пуповину после рождения ребенка натягивать нельзя.
- ▶ Ребёнок должен быть расположен на одном уровне с роженицей (профилактика анемии или полицитемии)
- ▶ Пуповина перевязывается в два этапа через 1-3 минут после рождения (но не позднее 10 минут после рождения)
- ▶ На первом этапе, с прекращением пульсации пуповины, на нее накладываются 2 стерильных зажима Кохера: один на расстоянии 10 см от пупочного кольца, второй на 2 см кнаружи от первого зажима.
- ▶ Участок пуповины между зажимами обрабатывают 70% р-ром этилового спирта, затем рассекают стерильными ножницами. После этого новорожденного заворачивают в стерильные пеленки и переносят на пеленальный стол с обогревом, при необходимости проводят гигиеническую ванну.
- ▶ Второму этапу должна предшествовать повторная обработка рук акушерки.
- ▶ Остаток пуповины протирают стерильной салфеткой, туго сжимают между большим и указательным пальцами и между браншами зажима Кохера накладывают скобки Роговина или пуповину перевязывают шелковой лигатурой на расстоянии 1 см от пупочного кольца.
- ▶ Остаток пуповины отсекают стерильными ножницами, и поверхность среза обрабатывают 70% раствором этилового спирта или 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина



Профилактика гонобленнореи (офтальмобленнореи)



- ▶ Проводится во время первичного туалета
- ▶ Протереть веки от наружного угла к внутреннему сухим ватным шариком (отдельным ватным шариком для каждого глаза)
- ▶ Пальцами одной руки осторожно оттягивают нижнее веко вниз и закладывают за нижнее веко мази **тетрациклина гидрохлорида 1%** или **эритромицина фосфата 10 000 Ед в 1 г** (глазная мазь, полоска длиной до 1 см)
- ▶ Затем, при смыкании век, осторожно вытирают избыток раствора



Вторичная обработка новорожденного



- ▶ Проводится на животе у матери или на столе с подогревом, не ранее, чем через 40-60 минут и не позже, чем через 2 часа после рождения.
- ▶ Кожа ребенка в родильном зале не обрабатывается, не обмывается, смазка (vernix caseosa) не снимается. При необходимости достаточно протирания кожи теплой пеленкой.
- ▶ Для вторичной обработки пуповины используется одноразовый пластмассовый зажим, который накладывается на пуповинный остаток на расстоянии от пупочного кольца до 1 см.
- ▶ После наложения зажима ткань пуповины выше зажима отсекают, вытирают кровь.
- ▶ **Затем проводят антропометрические измерения.**
- ▶ Обмывание ребенка под краном в родильном зале не рекомендуется
- ▶ После полного осмотра, ребенка, при отсутствии противопоказаний, укладывают на живот матери (эпигастральная область), укрывают пеленкой, прикладывают к груди; оставляют с матерью на 30 – 60 минут

При стабильном состоянии новорожденного необходимые процедуры (взвешивание, вторичная обработка пуповинного остатка, пеленание) рекомендуется проводить после первого прикладывания ребенка к груди, после того, как он получит первые капли молозива.

Антропометрия новорожденного



Контакт «кожа к коже»



обеспечение:

- ▶ температурной адаптации;
- ▶ колонизации материнской микрофлорой;
- ▶ раннего начала грудного вскармливания;
- ▶ психо-эмоционального контакта матери и ребенка;
- ▶ формирования родственных связей.



Первое прикладывание к груди



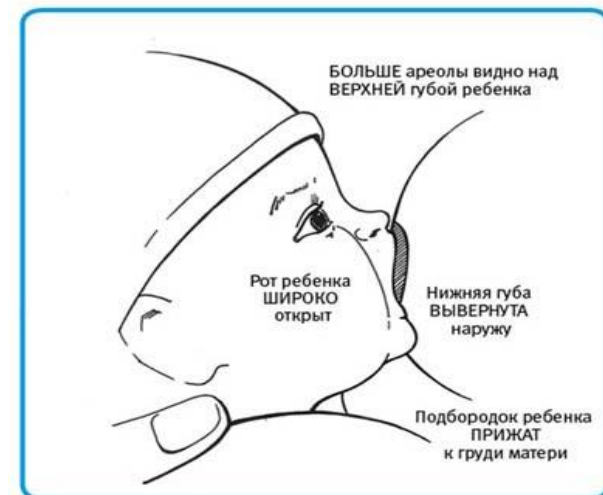
Сразу же после рождения здоровый ребёнок инстинктивно начинает поиск пищи. В течение нескольких часов жизни новорождённый бодрствует, активен и готов к кормлению. Ребёнок может быть менее активным, если матери во время родов были назначены седативные или обезболивающие лекарственные препараты.

Очень важно обеспечить полноценное общение матери и ребёнка сразу после родов. Для того, чтобы первое кормление было успешным, необходимо:

- принимая роды, нужно свести объём медицинского вмешательства к минимуму;
- по возможности избегать применения лекарственных средств, проникающих через плаценту и вызывающих сонливость у ребёнка;
- обеспечить ребёнку контакт с матерью «кожа к коже»;
- предоставить матери и ребёнку возможность общаться друг с другом;
- помочь ребёнку найти грудь, показав матери, как правильно приложить его.

У женщины не должно быть ощущения, что в первые сутки грудь полная. Это не означает, что в груди нет молока, молозиво вырабатывается в небольшом объеме, а «зрелое» молоко появится в течение нескольких дней.

Помогите приложить ребенка к груди, обратите внимание на признаки правильного прикладывания (вывернутая нижняя губа, полный захват ареолы соска, нос прижат к груди).



Актуальность совместного пребывания



- ▶ Способствует более раннему восстановлению синхронизации адаптационных процессов, происходящих в организме матери и новорожденного после разобщения единой биологической системы «мать-плацента-плод».
- ▶ Ведет к снижению материнской и детской заболеваемости, а также увеличению числа грудных детей, находящихся на естественном вскармливании.
- ▶ Обеспечивает активное участие матери в уходе за новорожденным ребенком (пеленание, туалет кожных покровов и слизистых оболочек, кормление).



Противопоказания для совместного пребывания матери и ребенка



Со стороны матери

- ☐ Поздние гестозы беременных
- ☐ Экстрагенитальные заболевания в периоде декомпенсации
- ☐ Оперативное вмешательство
- ☐ Стремительные или затяжные роды
- ☐ Разрывы или разрезы промежности

Со стороны ребенка

- ☐ Недоношенность и незрелость
- ☐ Длительная внутриутробная гипоксия
- ☐ Внутриутробная гипотрофия плода II-III степени
- ☐ Внутричерепная и другие виды родовых травм
- ☐ Асфиксия плода при рождении, аномалии развития и уродства
- ☐ Гемолитическая болезнь новорожденного

Недоношенные, больные дети. Кювез



- Кувез состоит из корпуса и кабины.
- В корпусе – электротехническое оборудование, автоматическая электронная система и приборный блок.
- Кабина состоит из колпака, матраса.
- Прозрачный колпак позволяет наблюдать за новорожденным, снижает потери тепла.
- Стенки колпака имеют дверцы доступа и отверстия для инфузионных и дыхательных трубок открывающиеся панель и дверцы, выдвижная кроватка с изменяемым углом наклона обеспечивают удобный доступ к ребенку для лечения и ухода за ним.
- В кувезе регулируются температура, влажность воздуха, концентрация кислорода



Кювез закрытого типа



- ▶ Температура в кузове для детей с массой тела 1200-1500 г. – 32-33°C, более 1500 г. – 31 -32°C.
- ▶ Влажность в первые трое суток должна быть максимальной (90-100%), затем постепенно снижается до 60-65%.
- ▶ Для контроля за температурой тела ее измеряют каждые 3-4 ч в течение всего пребывания ребенка в кувезе.
- ▶ Подключение в кувез кислорода и длительность его применения зависят от состояния ребенка, степени недоношенности и синдрома дыхательных расстройств. Концентрация кислорода в кувезе не должна превышать 30-38%.
- ▶ При выживании детей в кувезе необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенический режим. Через каждые 2-3 дня нужно проводить дезинфекцию.
- ▶ В кювез ребенка помещают раздетым, что способствует правильному дыханию и свободным движениям.
- ▶ Уход за недоношенным и кормление производят, не вынимая ребенка из кувеза. Перед использованием кувез должен быть хорошо проветрен и тщательно протерт раствором дезинфицирующего средства.
- ▶ Температура воздуха в палате для недоношенных должна быть +24... +26°C.

Алгоритм профилактики гипотермии новорожденных. Тепловая цепочка



- ▶ Подготовка теплого родового зала (температура 26-28 градусов)
- ▶ Включение источника лучистого тепла за 30 минут до родов
- ▶ Поверхности, на которые выкладывают ребенка, должны быть чистыми и теплыми. Необходимо заранее подготовить согретые пеленки для обсушивания ребенка, теплые пеленки и одеяла
- ▶ После рождения немедленно обсушить тело ребенка. Необходима смена мокрой пеленки и её замена на сухую и теплую
- ▶ Первое прикладывание ребенка к материнской груди в родильном зале
- ▶ Обеспечение раннего контакта «кожа-к-коже» новорожденного и матери: ребенок должен быть обсушен, укрыт теплой сухой пеленкой и/или одеялом, мать и ребенка укрывают одним одеялом
- ▶ На голове у ребенка должна быть надета шапочка
- ▶ Термометрия всем новорожденным должна проводиться в родильном зале в течение 2-х часов 4-хкратно и сразу после перевода в послеродовую палату



Основные принципы ухода за новорожденным



- ▶ Поддержание нормальной температуры тела новорожденного
- ▶ Возможность оказания своевременной качественной первичной реанимационной помощи
- ▶ Обеспечение возможного раннего начала грудного вскармливания и совместного пребывания матери и ребенка
- ▶ Профилактика инфекционной заболеваемости
- ▶ Доброжелательная обстановка во время родов
- ▶ Содействие раннему формированию привязанности между матерью и ребенком
- ▶ Активное вовлечение семьи матери в уход за ребенком

Согласовано	Утверждаю
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по неонатологии, профессор, д.м.н. Д.О.Иванов «01» сентября 2015 г.	Председатель Совета Межрегиональной Ассоциации неонатологов, профессор, д.м.н. Д.Н.Дегтярев «24» июня 2015 г.

БАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННОМУ
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
И В ПОСЛЕРОДОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Клинические рекомендации



Периоды детства и особенности ухода

Периоды детства



▶ Период новорожденности:

- ранний неонатальный (0 – 168 часов)
- поздний неонатальный (с 8-ых (169 часа) до 28 сутки)

Адаптация ребенка к внеутробному существованию (начало легочного дыхания и функционирование малого круга кровообращения, изменение энергетического обмена и терморегуляции, начало энтерального питания)

Интенсивное развитие анализаторов (прежде всего зрительного), начало развития координации движений, образование условных рефлексов, возникновение эмоционального, зрительного и тактильного контактов с матерью.

▶ Период грудного возраста – от 29-го дня жизни до 1 года.

Завершение адаптации к внеутробной жизни, интенсивное физическое, нервно-психическое, моторное и интеллектуальное развитие ребенка

▶ Преддошкольный (ясельный) период – от 1 года до 3 лет

Снижение темпов физического развития детей, «созревание» основных физиологических систем (увеличение мышечной массы, прорезывание молочных зубов, расширение двигательных возможностей, интенсивное развитие анализаторов, речь

▶ Дошкольный период – от 3 до 7 лет

Дифференцировка строения различных внутренних органов, интенсивно развивается интеллект, память, совершенствуются координированные движения, формируются индивидуальные интересы и увлечения

▶ Младший школьный возраст – от 7 до 11 лет

Происходит замена молочных зубов постоянными, улучшается память, повышается интеллект, формируются самостоятельность и волевые качества, расширяется круг интересов

▶ Старший школьный возраст – с 12 до 17–18 лет

Период психологического развития, формирования воли, сознательности, гражданственности, нравственности, резкого изменения функций эндокринных желез, полового развития и пубертатного скачка роста

Факторы, влияющие на состояние здоровья детей (ВОЗ)



- социальные факторы – около 50%,
- биологические факторы – около 20%,
- антропогенных факторов – около 20%;
- медицинское обслуживание – до 10%.

Благоприятные (оздоровительные)		Неблагоприятные (факторы риска)	
1.	Соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам	1.	Нарушения гигиенических требований к окружающей среде и условиям жизнедеятельности
2.	Оптимальный двигательный режим.	2.	Недостаточная или избыточная двигательная активность.
3.	Закаливание.	3.	Нарушения режима дня и учебно-воспитательного процесса.
4.	Сбалансированное питание.	4.	Недостатки в организации питания.
5.	Рациональный суточный режим.	5.	Отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни.
6.	Здоровый образ жизни.	6.	Неблагоприятный психологический климат в семье и коллективе.



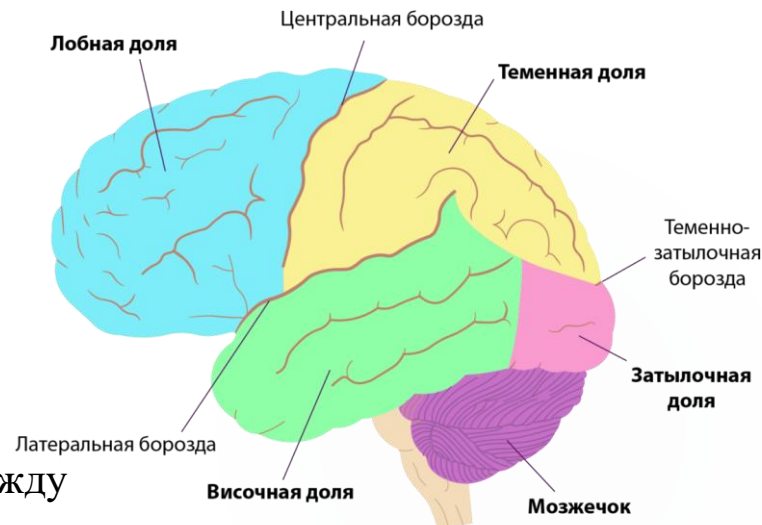
Анатомо-физиологические особенности новорожденных

Нервная система



ГОЛОВНОЙ МОЗГ функционально незрелый

- ▶ Масса головного мозга $1/8 - 1/9$ массы тела
- ▶ Борозды и извилины имеют недостаточный рельеф
- ▶ Мозжечок развит слабо
- ▶ Миелиновые оболочки отсутствуют
- ▶ Ткань мозга богата водой, кровоснабжение обильное.
- ▶ Количество нервных клеток как у взрослых, но связи между ними развиты слабо.



Следствия: отсутствие координации движений, легкая травматизация, но и более высокие восстановительные способности, чем у взрослых.

СПИННОЙ МОЗГ развит лучше, чем головной.

Следствие: наличие безусловных рефлексов



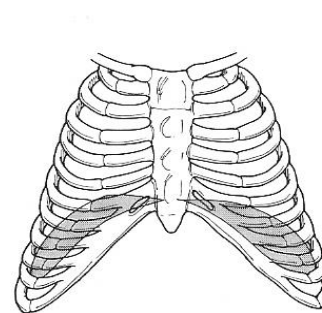
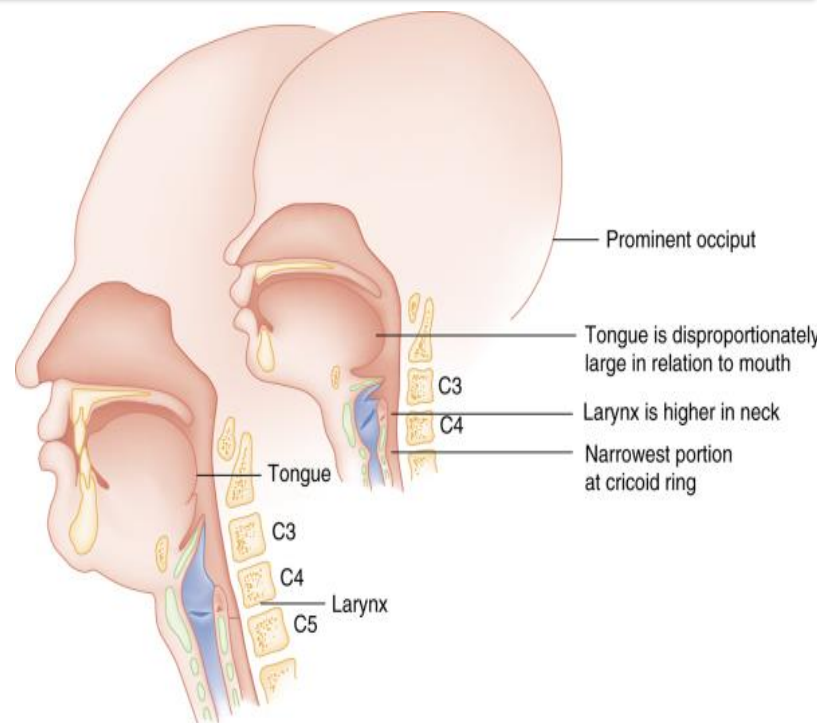
Дыхательная система



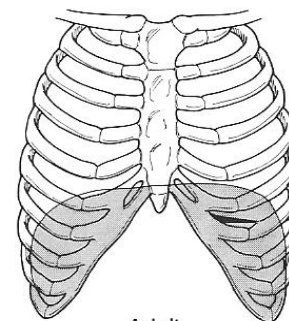
- ▶ Дыхательные пути узкие, слизистая оболочка рыхлая, богата сосудами, функция слизистых желез снижена
- ▶ Носовые ходы узкие, нижний носовой ход отсутствует
- ▶ Глотка узкая, евстахиева труба широкая и короткая
- ▶ Гортань широкая вверху с сужением в подвязочном пространстве
- ▶ Трахея узкая, её хрящи мягкие, могут спадаться
- ▶ Бронхи узкие, хрящи мягкие, склонные к спадению. Правый бронх расположен почти вертикально.
- ▶ Легкие богаты соединительной тканью, малоэластичны, маловоздушны
- ▶ Дыхание диафрагмальное, поверхностное
- ▶ ЧД 60 (до 80) в мин., ЧД/ЧСС = 1/2,5 (1/3)

Следствия:

- Подверженность инфекционным заболеваниям ВДП
- Склонность к отеку (частая заложенность носа)
- Врожденный стридор
- Осложнения ОРВИ – стеноз гортани, обструкция бронхов
- Пневмония с отеком, ателектазом



Newborn



Adult

Сердечно-сосудистая система

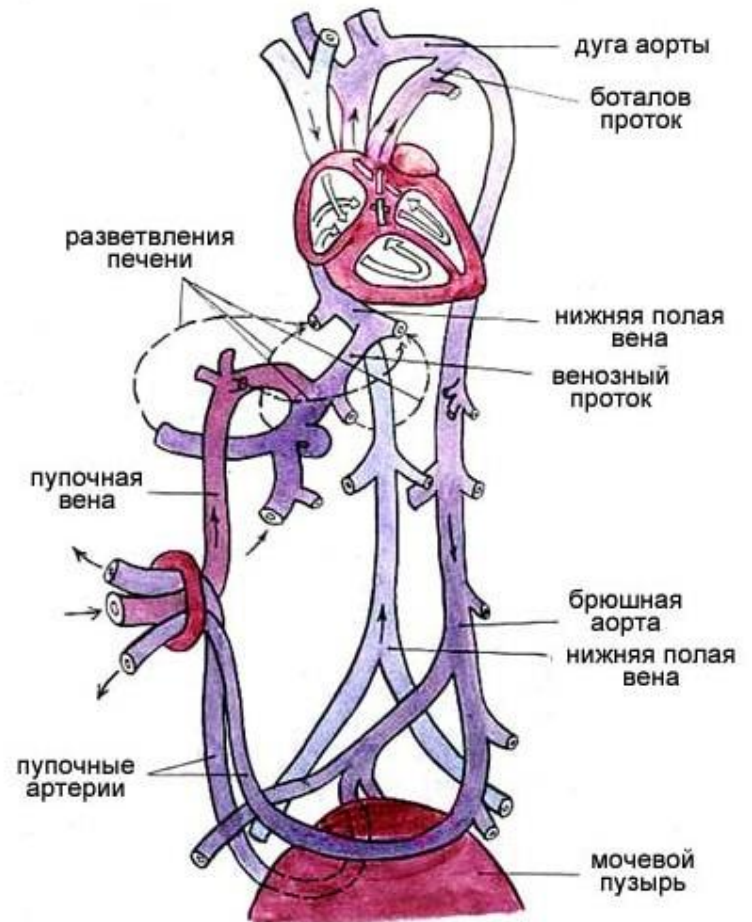


- ▶ Наличие плодных коммуникаций: открытое овальное окно, Боталлов (артериальный) проток, венозный(Аранциев) проток
- ▶ Сосуды развиты хорошо, артерии – лучше, чем вены
- ▶ Пульс ускорен и аритмичен, ЧСС 80 – 180 в мин.

Закрытие коммуникаций:

- ▶ **Функциональное закрытие** после рождения
- ▶ **Анатомическое закрытие:**
 - ▶ сначала закрывается венозный проток к 4 неделе, а на его месте образуется круглая связка печени.
 - ▶ Затем закрывается артериальный проток, в результате спазма сосудов из-за гипоксии в течение 8 недель.
 - ▶ Самым последним закрывается овальное окно, в течение первого полугодия жизни.

Следствие: часто наличие функциональных сердечных шумов.



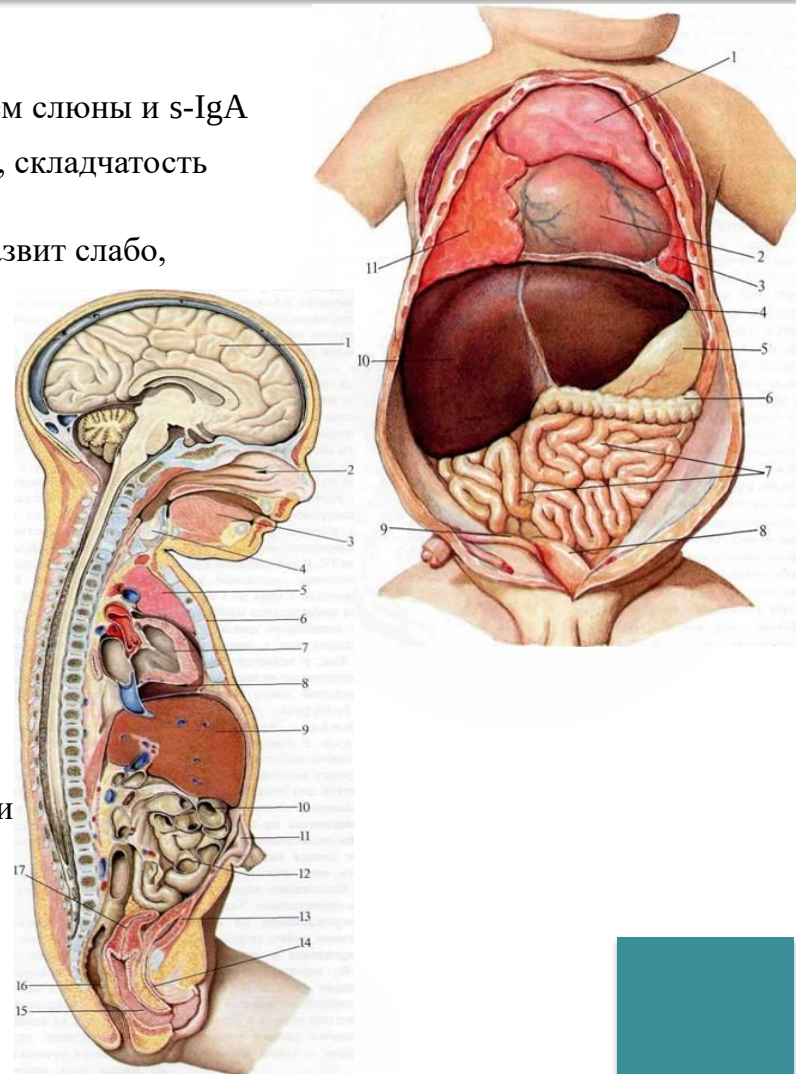
Пищеварительная система



- ▶ Пищеварительный тракт относительно длиннее, чем у взрослых
- ▶ Слизистая оболочка относительно сухая, с пониженным содержанием слюны и s-IgA
- ▶ Приспособления для сосания: подушечки Биша, валики вдоль десен, складчатость слизистой, относительно большой язык
- ▶ Желудок распложен почти горизонтально, кардиальный сфинктер развит слабо, пилорический – хорошо
- ▶ Мышечный слой кишечника слабо иннервирован
- ▶ Проницаемость кишечной стенки выше
- ▶ Кишечник практически стерилен при рождении
- ▶ Первородный стул – меконий
- ▶ Печень относительно крупнее, функции развиты слабо, особенно детоксикационная

Следствия:

- Подверженность кишечным инфекциям
- Срыгивания (норма – до 1 столовой ложки в каждое кормление)
- Легко нарушается перистальтика, возникает вздутие живота, колики
- Легкое развитие токсикоза, вплоть до нейротоксикоза
- Переходная флора (весь первый год жизни)
- Переход на обычный стул с 4-5 дня жизни
- Печень выступает из-под края реберной дуги на 1-2 см



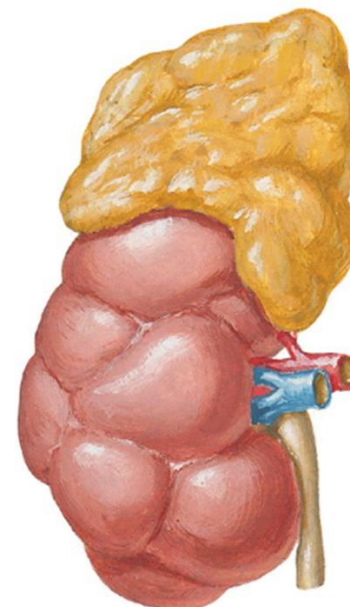
Мочевыделительная система



- ▶ Почки – анатомическая и функциональная незрелость, меньшее количество клубочков, сниженная концентрационная способность
- ▶ Мочевой пузырь – мышечный слой развит слабо, нет контроля со стороны ЦНС
- ▶ Мочеиспускательный канал относительно короче, чем у взрослых. Девочки – 0,5-1 см, мальчики – 5-6 см, имеют физиологический фимоз.

СЛЕДСТВИЯ:

- Низкая относительная плотность мочи, частые мочеиспускания (20-25 раз в сутки)
- Непроизвольные мочеиспускания
- Легкое восходящее инфицирование



Иммунная система

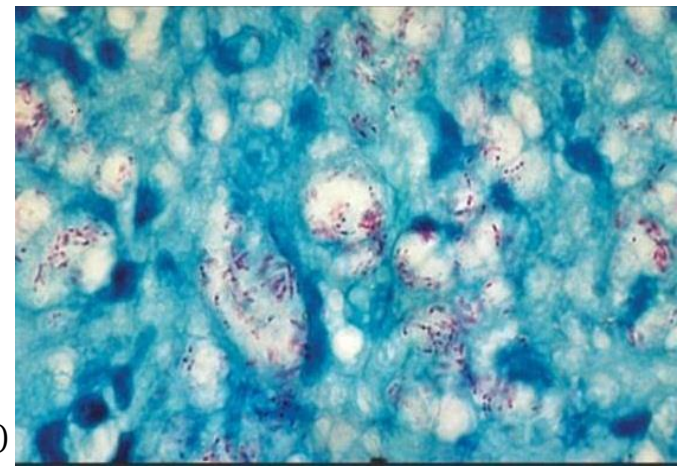
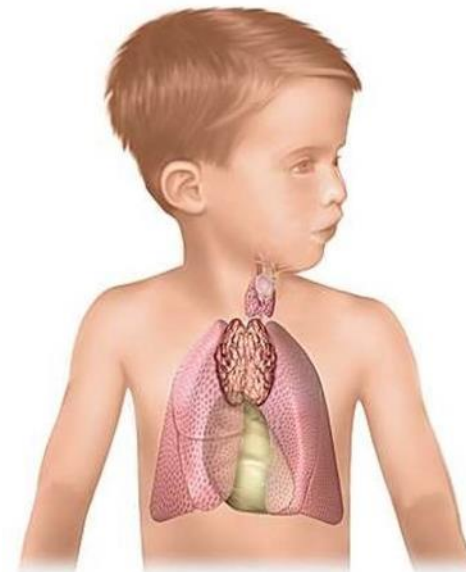


ИММУННАЯ СИСТЕМА

- ▶ *Клеточное звено* – количество Т- и В-клеток выше, но они функционально менее активны
- ▶ *Гуморальное звено* – снижение уровня иммуноглобулинов всех классов
- ▶ *Фагоцитоз* – несовершенство завершающей фазы
- ▶ Неспецифические факторы – высокое содержание лизоцима; высокая способность к продукции интерферона

Следствия:

- Несовершенное антителообразование
- Аллергические реакции крайне редки
- Активный местный иммунитет и противовирусный иммунитет.



Пример незавершенного фагоцитоза
(Микобактерии, окраска по Цилю-Нильсену)

- ▶ Роговой слой тонкий, эпидермис сочный, рыхлый; базальная мембрана развита слабо.
- ▶ Кровеносные сосуды образуют густую сеть, просвет их шире, чем у взрослых.
- ▶ Подкожно-жировой слой развит, образует складки; присутствует бурый жир.
- ▶ Потовые железы развиты, но не функционируют.
- ▶ Сальные железы функционируют с внутриутробного периода.
- ▶ Волосы – пушковые.

Следствия:

- Повышенная ранимость, но и лучшая регенерация, эпидермис легко отслаивается с образованием пузырей.
- Легкое инфицирование
- Недостаточная терморегуляторная функция (легкое перегревание и переохлаждение)



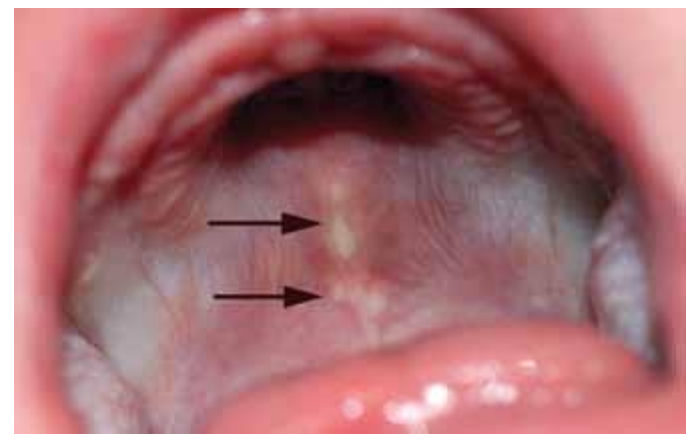
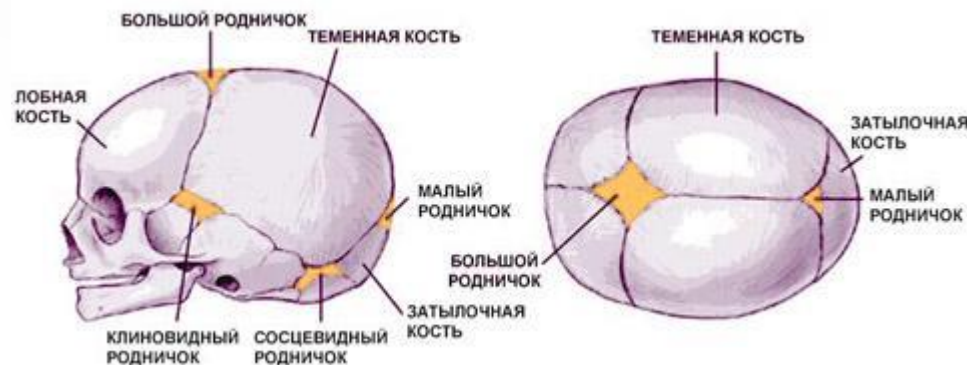
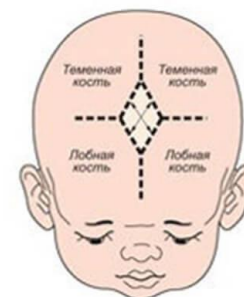
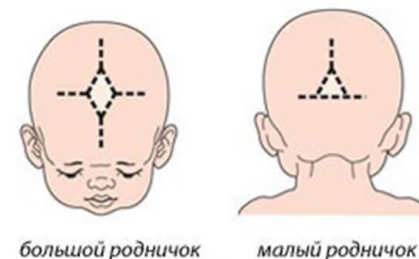
Костно-мышечная система



- ▶ Костная ткань бедна минеральными солями, богата водой, имеет обильное кровоснабжение.
- ▶ Череп имеет роднички, швы черепа широкие, закрыты не полностью.
- ▶ Позвоночник не имеет физиологических изгибов.
- ▶ Зубы отсутствуют (имеются зачатки постоянных и молочных зубов)
- ▶ Мышцы развиты слабо, имеется физиологический гипертонус с преобладанием тонуса сгибателей.

Следствия:

- Кости более гибкие, регенерация лучше, но легко деформируются.
- Череп способен изменять свою форму при прохождении через родовые пути, возможна транзиторная послеродовая деформация черепа.
- Открытые роднички дают возможность роста мозга ребенка
- Нормальная поза ребенка – гипертонус, флексорная



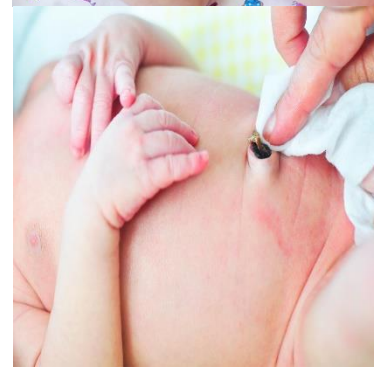
Уход за новорожденными



- ▶ Уход осуществляется с учетом состояния ребёнка. Он не должен причинять неприятных ощущений.
- ▶ Ежедневный уход за новорожденным включает в себя следующие мероприятия: измерение массы и температуры тела, туалет пуповинного остатка и пупочной ранки, туалет кожи и слизистых оболочек.
- ▶ Измерение массы тела новорожденных производят ежедневно в одно и то же время, как правило, утром перед первым кормлением.



Уход за пуповинным остатком и пупочной ранкой

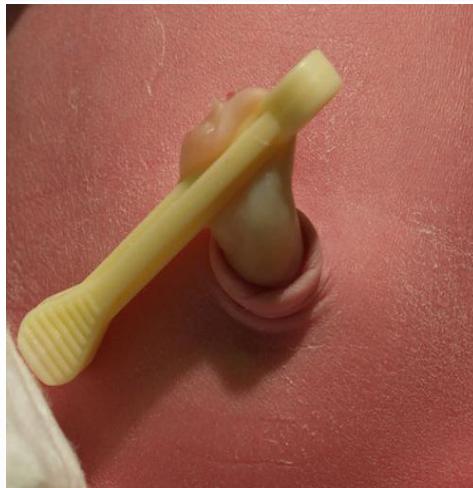


- ▶ Для ухода за пуповинным остатком не требуется создания стерильных условий (ВОЗ).
- ▶ Пуповинный остаток сначала высыхает, затем мумифицируется при воздействии воздуха и отпадает.
- ▶ У каждого ребенка свой срок отпадения пуповины – это зависит от ее толщины. Считается, что он должен отпасть до 14 дня жизни.
- ▶ **Не рекомендуется** обрабатывать пуповинный остаток какими-либо антисептиками (растворы анилиновых красителей, спирт, раствор калия перманганата и т. п.)
- ▶ Достаточно содержать его сухим и чистым, предохранять от загрязнения мочой, калом, а также от травмирования при тугом пеленании или использовании одноразовых подгузников с тугой фиксацией.
- ▶ Доказано, что местное использование антисептиков не только не уменьшает частоту инфекций, но и способствует задержке спонтанного отпадения пуповинного остатка.
- ▶ В случае загрязнения пуповинный остаток и кожу вокруг пупочного кольца можно промыть водой, и осушить чистой ватой или марлей.
- ▶ Купание разрешено в кипяченой воде с последующим высушиванием остатка пуповины.
- ▶ Не рекомендуется пользоваться повязками и дополнительным подвязыванием пуповины для ускорения процесса мумификации.
- ▶ Насильственное удаление (отсечение) пуповинного остатка не рекомендуется, так как подобная процедура опасна, и может осложниться кровотечением, ранением стенки кишки при недиагностированной грыже пупочного канатика, инфицированием.

Динамика заживления пупочной ранки



Амниотическая оболочка пуповины только родившегося ребенка гладкая, блестящая упруго-эластичная



По истечении 3 - 5 часов после рождения ребенка пуповина теряет блеск, становится матовой в связи с высыханием амниотической оболочки.



На второй день пуповина начинает засыхать



На третий день сморщивается, становится сухой твердой, коричневого цвета - мумифицируется



Между пятым и десятым днями от рождения отпадает

В течение трех четырех недель рана зарубцовывается, рубец находится на дне круглой ямки с высокими краями.

На восьмую неделю пупок приобретает окончательную форму





Купание



- ▶ Первую гигиеническую ванну делают новорожденному после отпадения пуповины и эпителизации пупочной ранки (7–10-й день жизни).
- ▶ В течение первых 6 месяцев ребенка купают ежедневно, во втором полугодии – через день.
- ▶ Температура воды до 6-и мес – 36,5-37°C, после 6 мес – 36 – 36,5 °C



Общие принципы купания новорожденных



**Продолжительность
ванны на первом году
жизни не более 5–10 мин.**

▶ Температура воды для купания от 36,5°C до 37,0°C (использовать термометр); температура в помещении 24°C; закрытая дверь в помещении, в котором проводится купание; для обсушивания новорожденного использовать предварительно подогретые пеленки (обсушивание путем промакивания)

▶ Используйте для купания теплую водопроводную воду. Использование водопроводной воды можно считать безопасным, если ее качество соответствует гигиеническим стандартам.

▶ Купание только в воде по сравнению с купанием в воде с использованием детских моющих средств не показало отличий в степени микробной колонизации кожи после данной процедуры как у недоношенных, так и доношенных новорожденных.

▶ Со временем колонизация кожи усиливается независимо от использования очищающих средств во время купания.

▶ Необходимо использовать моющие средства с составом наиболее близким к физиологическим свойствам кожи в этот период (с нейтральным или немного кислым pH (5,5)).

▶ Моющее средство не должно попадать на слизистую глаз. Мигательный рефлекс существует у младенцев с рождения, однако он менее быстрый, по сравнению со взрослыми.

▶ По возможности нужно избегать использования антибактериального мыла (из-за его потенциального отрицательного воздействия на нормальную колонизацию кожи).



Подмывание



- ▶ После каждого мочеиспускания и дефекации ребенка подмывают.
- ▶ Девочек подмывают спереди назад, чтобы избежать загрязнения и инфицирования мочеполовых путей.
- ▶ Недопустимо подмывать детей непроточной водой, например в тазике.



Утренний туалет

Уход за кожей и слизистыми



**Вращательные
движения**

Тёплой кипяченой водой Жгутик из стерильной ваты
Снаружи внутрь с вазелиновым маслом
на 1 – 1,5 см

Ватным жгутиком
наружный слуховой проход

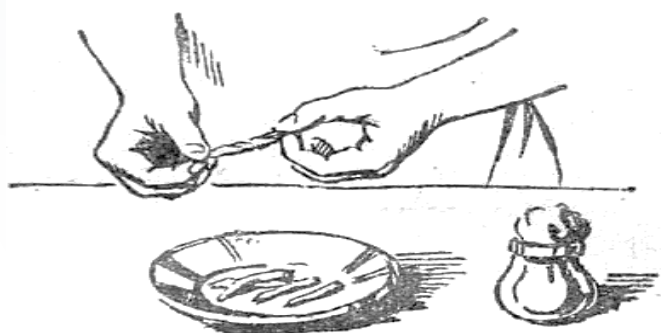


Рис. 9. Так готовят ватные жгутики для прочистки носа и ушей ребенка.



Элементы утреннего туалета ребенка

Глаза	обрабатывают ватными тампонами, смоченными кипяченой водой, от наружного угла глаза к внутреннему (для каждого глаза используют отдельный тампон). Важно при этом следить, чтобы вода не попадала из одного глаза в другой (поэтому промывая правый глаз, голову ребенка тоже поворачивают вправо, и наоборот)	
Нос	Туалет проводят тугими ватными жгутиками, смоченными в стерильном растительном масле (особенно если в носовых ходах имеется сухой секрет или корочка) или кипяченой воде (для каждого носового хода используют отдельный жгутик) поступательно-вращательными движениями на глубину до 1-1,5 см.	
Уши	Наружные слуховые проходы прочищают тугими ватными жгутиками сухими или смоченными в стерильном растительном масле (для размягчения корочек); движения вращательные, в пределах видимости; для каждого прохода – отдельный жгутик. Обрабатывают 1 раз в неделю или по мере необходимости.	

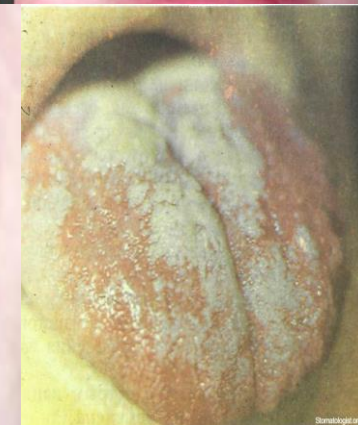
Орофарингеальный кандидоз «Молочница»



Кандидоз – одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибами рода *Candida* (*Candida albicans*). Всех представителей данного рода относят к условно-патогенным.

Причины:

- осложненное течение родов (раннее отхождение околоплодных вод);
- инфекция, занесенная во время родов;
- позднее первичное прикладывание детей к груди матери (на 2-5 день жизни);
- ранний перевод на искусственное вскармливание с использованием смесей с повышенным содержанием глюкозы;
- общая слабость иммунитета;
- недоедание;
- нарушения функций желудочно-кишечного тракта;
- диарея;
- прием антибиотиков глюкокортикоидных, гормонов, цитостатиков;
- длительное воздействие неблагоприятных физических факторов (например, теплая влажная среда).



Характеристика кандидоза



- ▶ слизистая полости рта гиперемирована, отечна,
- ▶ на языке творожисто-пленчатый налет белесоватого цвета.
- ▶ на слизистой оболочке щек, губ, неба налет снимается с трудом, под ним – гиперемированная слизистая, при контакте – болезненна.
- ▶ Образования носят точечный или точечно-островковый характер
- ▶ При среднетяжелой форме грибы проникают в поверхностные, а затем и глубокие слои эпителия, что обуславливает затрудненное снятие налета, на месте которого образуется эрозированная, иногда кровоточащая поверхность слизистой оболочки.
- ▶ Регионарные лимфатические узлы могут быть несколько увеличены и болезненны.



Мероприятия ухода



- ▶ До 6- 8 раз в сутки 7 дней
- ▶ **Оценка груди матери (при ГВ) или сосок (при ИВ), поддержание гигиены**
- ▶ При легкой форме – местная терапия ощелачивающими (2% раствор пищевой соды, 2% натрия тетрабората, 0,25% борный раствор) и дезинфицирующими (анилиновые красители – раствор Люголя, метиленовый синий, «Повидон-Йод», Мирамистин, Хлоргексидин) средствами.
- ▶ При неэффективности – антифунгальные препараты (Кандид, Нистатин).
- Тщательно вымыть руки, обработать антисептиком.
- Намотать на указательный палец небольшой кусочек марли.
- Обмокнуть палец с марлей в ощелачивающий раствор / раствор дезинфицирующего средства.
- Аккуратно, без нажима удалить налет на языке и щеках.
- Марлю выбросить, намотать новый кусочек.
- Или воспользоваться насадкой-распылителем
- ▶ При средне- и тяжелых формах – коррекция терапии у врача-педиатра!



Кувез



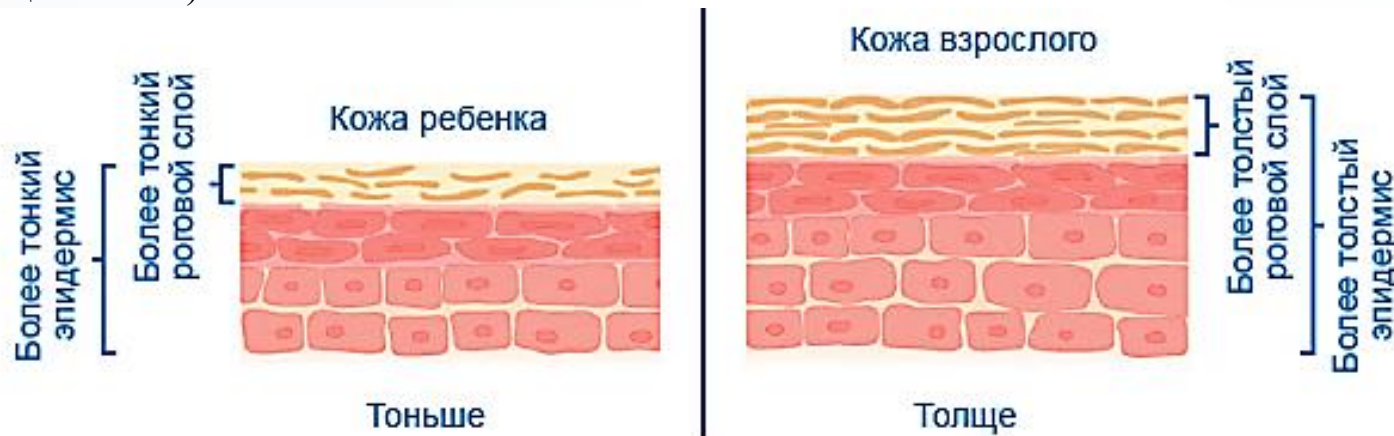
Особенности ухода на первом году жизни ребенка



Уход за кожей



- ▶ Кожа ребенка раннего возраста хорошо кровоснабжается. Очень высока способность кожи ребенка к регенерации.
- ▶ Роговой слой тонкий и состоит из 2-3 слоев слабо связанных между собой клеток.
- ▶ Базальная мембрана (между эпидермисом и дермой) не обеспечивает прочную связь основных слоев кожи, что может привести (при заболевании, травматизации) к легкому отделению эпидермиса.
- ▶ Ввиду морфологической незрелости кожи плохо развита защитная ее функция. Кожа чрезвычайно ранима и склонна к мацерации, легко инфицируется, доступна вредному воздействию химических раздражителей.
- ▶ Несовершенна терморегуляторная функция кожи, это связано как с недостаточно развитой функцией терморегуляции ЦНС, так и с недоразвитием протоков потовых желез (потоотделение начинается с 3-4 месяцев жизни).



Уход за кожей



- ▶ При каждом подмывании, купании ребёнка необходимо оценивать состояние кожных покровов
- ▶ При неправильном уходе за кожей возникает пелёночный дерматит, который представляет собой раздражение кожи в области, контактирующей с подгузником.
- ▶ Основная причина развития пеленочного дерматита – дефекты ухода (редкая смена подгузника, тугое пеленание).
- ▶ Пелёночный дерматит не представляет серьёзной угрозы для здоровья ребёнка, но раздражение кожи очень болезненно, вызывает страдание и беспокойство ребёнка, что отражается на его самочувствии.
- ▶ Запущенные случаи пеленочного дерматита могут привести к инфицированию.



Опрелости



➤ **Опрелость – нарушение целостности кожных покровов, образующих крупные складки.**

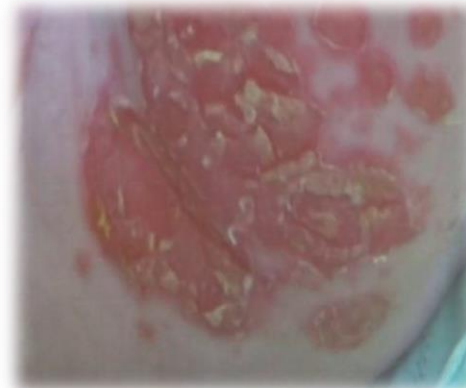
➤ Опрелость развивается в результате раздражающего и длительного увлажняющего влияния продуктов кожной секреции (кожного сала, пота), а также трения соприкасающихся поверхностей кожи (подгузники, пеленки).

➤ Проявляется опрелость в виде покраснения кожных складок (бедренно-мошоночной, межъягодичной, подмышечных, под молочными железами у женщин, у тучных людей в складках живота, иногда в заушных складках, между пальцами стоп и кистей).

➤ При опрелости I степени специального лечения чаще всего не требуется. Ежедневное частое промывание кожных складок тела теплой водой с мыльным средством и антисептическим раствором, затем пораженные места промокаются хорошо впитывающей влагу тканью или сушатся.

➤ При опрелости II степени, помимо перечисленных выше мероприятий, используют «болтушки» (они изготавливаются в аптеке по рецепту), содержащие подсушивающие вещества (окись цинка, тальк).

➤ Опрелость III степени трудно поддается лечению, поэтому так важны профилактика и правильное лечение опрелостей более легких степеней. В течение нескольких дней на мокнущие поверхности накладывают примочки с растворами, назначенными врачом (1-2-ным % раствором танина, 0,25%-ным раствором нитрата серебра). После исчезновения мокнутия применяют цинковую пасту, эмульсии с бактерицидными веществами.



Подгузники



Независимо от типа подгузников (одноразовые или многоразовые), необходимо соблюдать правила ухода за ребёнком:

- ▶ менять подгузник при его наполнении;
- ▶ сразу менять подгузник после дефекации ребёнка;
- ▶ использовать «дышащие» подгузники;
- ▶ организовывать воздушные ванны как можно чаще в течение дня.

При использовании одноразовых подгузников кожа должна быть сухой; не рекомендуется применять жирные мази, кремы, создающие эффект компресса, что провоцирует развитие дерматита. Если на кожу нанесена мазь или крем, перед надеванием подгузника избыток средства необходимо удалить салфеткой.

Рекомендуется использовать для ухода за кожей новорожденного крем на водной основе, лосьоны, молочко.

При использовании многоразовых подгузников можно применять кремы и мази, так как создание прослойки между кожей и подгузником уменьшает риск раздражения.



ABCDE ухода за кожей детей



- **A (aeration)** – аэрация: не следует перегревать и кутать ребенка, чтобы не возникла потница
- **B (barrier)** – барьер: используйте крема под подгузник на основе цинка, чтобы создать защитную плёнку.
- **C (cleaning)** – очистка: нельзя использовать мыло: оно растворяет жир и сушит кожу. Нужны специальные очищающие детские средства. Они должны быть Ph-нейтральными (5,0-5,5).
- **D (diaper)** – подгузник должен быть качественным и его нужно регулярно менять.
- **E (education)** – образование. Родители должны владеть базовой информацией о гигиене ребёнка и повышать свои знания.



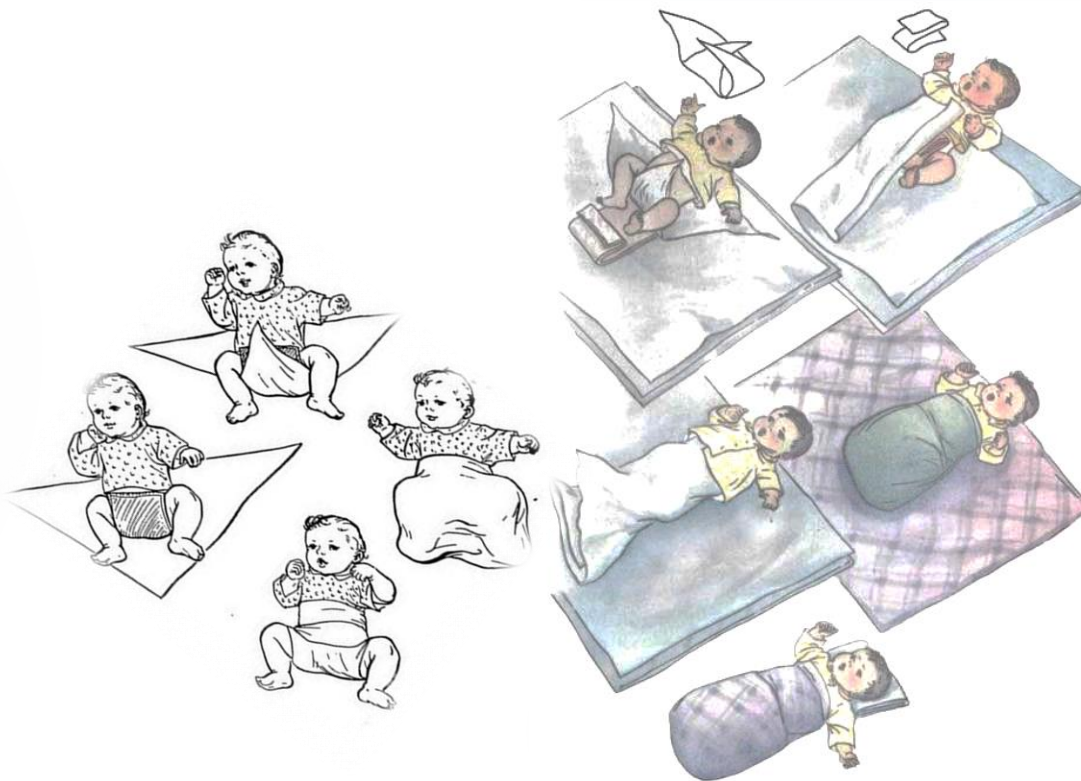
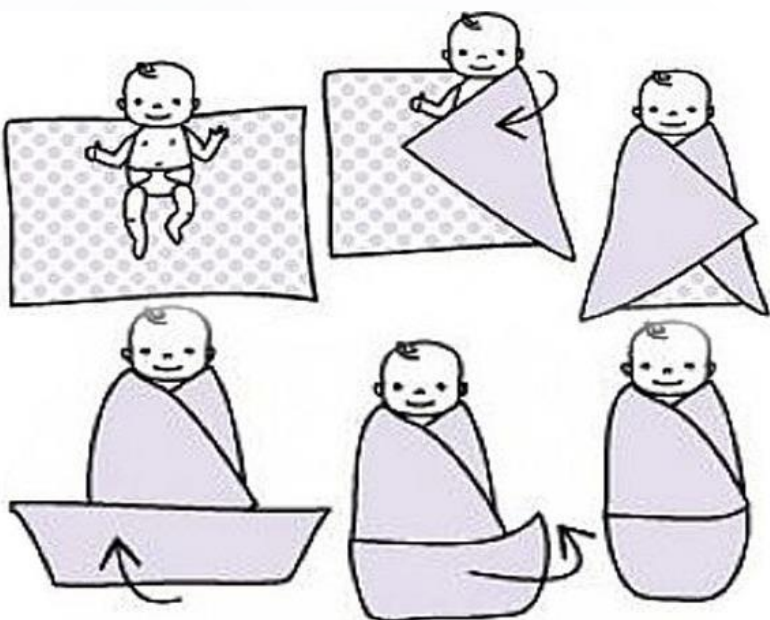
**Денис Владимирович
Заславский**

д.м.н., профессор,
главный дерматовенеролог
и косметолог СЗФО

Пеленание



- ▶ Дети успокаиваются, как только их заворачивают в пелёнки, чувствуя привычный ограниченный объём.
- ▶ К 2-3 месяцам при проявлении интереса к окружающему миру ребёнок стремится освободить из пелёнок руки. Это сигнал, чтобы перестать пеленать или использовать ползунки.

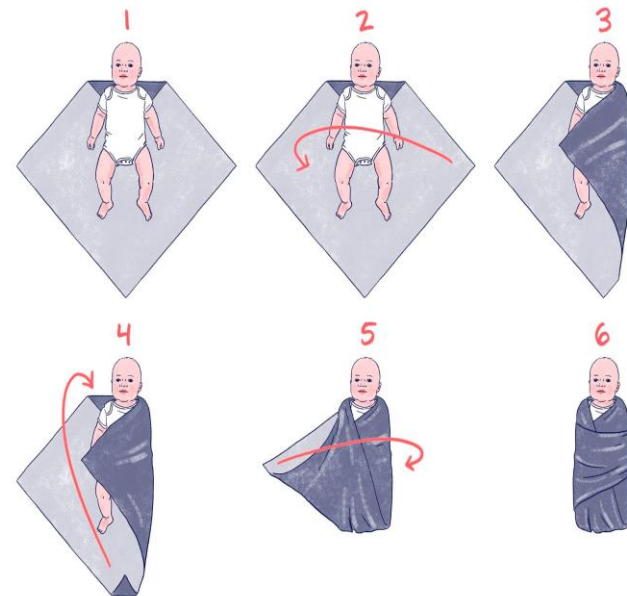


Тугое пеленание



не рекомендуется, так как приводит к нежелательным последствиям:

- блокированию движений диафрагмы, что затрудняет вентиляцию лёгких;
- нарушению циркуляции крови в конечностях;
- дисплазии тазобедренных суставов, особенно когда ноги ребенка жестко фиксируют в положении разгибания и приведения;
- уменьшению воздушной прослойки между телом ребёнка и одеждой, что ухудшает термоизоляцию; повышает риск как перегревания, так и гипотермии;
- ограничению движений конечностей ребёнка, что снижает возможности развития нервно-мышечной координации;
- затруднению правильного прикладывания к груди и грудного вскармливания (ребёнку трудно достаточно широко открыть рот и повернуть голову), что уменьшает вероятность успешной лактации.



Правила пеленания и одежда детей первого года жизни

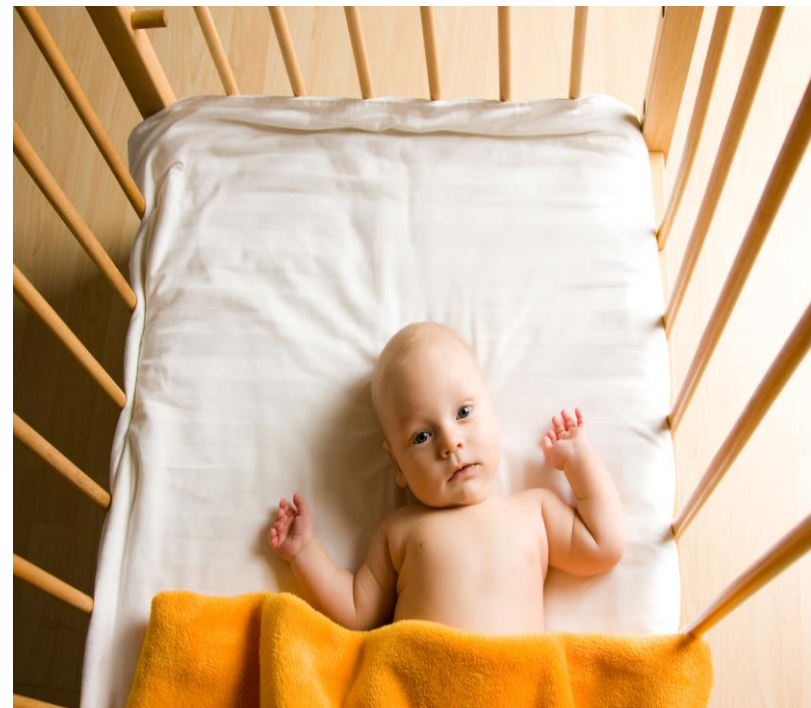


- ▶ Доношенного новорожденного первые 2-3 нед лучше пеленать с руками, а в последующем при соответствующей температуре воздуха в палате руки кладут поверх одеяла.
- ▶ Переодевание производят перед каждым кормлением, а детей с опрелостями или заболеваниями кожи – чаще.
- ▶ При условии ежедневной стирки и кипячения белья для детей первых месяцев жизни предусматривается определенный комплект белья.
- ▶ Тонкую распашонку запахивают на спине, а теплую – на груди ребенка. Рукава у теплой распашонки длиннее рук, зашивать их не следует. Нижний край распашонки должен прикрывать пупок.
- ▶ При пеленании ребенка кладут таким образом, чтобы верхний край пеленки доходил до подмышек.
- ▶ Подгузник помещают на промежность, после чего ребенка заворачивают в тонкую пелёнку. Подкладывают полиэтиленовую пеленку (клеенку) размером 30х30 см (верхний край на уровне поясицы, нижний – до уровня колен). Затем ребенка заворачивают в теплую пеленку. При необходимости ребенка накрывают сверху одеялом.
- ▶ **В настоящее время применяется широкое пеленание. Оно способствует физиологическому положению бедер, формированию головки бедренной кости и вертлужной впадины, препятствует вывиху головки бедренной кости в случае врожденной дисплазии тазобедренных суставов**

Профилактика деформаций скелета



- ▶ С целью предупреждения деформаций скелета на кроватку кладут плотный матрас латексный, кокосовый.
- ▶ Ребенка в кроватке необходимо укладывать в разных положениях, периодически брать на руки.
- ▶ В кроватке, особенно после кормления или в первые недели после рождения, ребенок должен лежать на спине без подушки (под наблюдением родителей).
- ▶ Такое положение ребенка при срыгивании и рвоте предупреждает попадание молока в дыхательные пути.
- ▶ Вместо подушки под голову ребенка кладут пеленку, сложенную в 4 раза.
- ▶ После 1,5-2 лет используется плоская невысокая подушка(высота 2-5см).



Пеленальный стол



- Корпус туалетно-пеленального стола должен быть изготовлен из древесины, металла и пластика. При использовании в конструкции пеленального стола текстильных элементов, они должны легко сниматься и чиститься.
- Используемые текстильные элементы должны быть выполнены из мягких тканей.
- **Габаритные размеры пеленального стола: высота 1000 мм, ширина 1010 мм, глубина 720 мм. Нагрузка – до 10 кг.**
- Конструкция пеленальных столов должна иметь бортики небольшой высоты с трех сторон, достаточной для предотвращения падения младенца или используемых взрослым пользователем аксессуаров с поверхности стола.



Одежда до 1 года



▶ В состав гардероба на каждый размер должны входить:

3-4 распашонки или легких рубашки, 2 теплых кофточки и одну шерстяную кофту, 2-3 ползунков, если вы используете памперсы, или 4-5, если пользуетесь марлевыми подгузниками, 3 брючек для разной погоды (для подросшего малыша), 1 шерстяные носочки и 2-3 хлопковых, чепчики.

▶ Одежда ребенку от 0 до 3 месяцев

Ползунки на бретельках – не сползают, когда малыш ползает на спине, отталкиваясь ногами.

Распашонка без пуговиц – можно заправить в ползунки или закрепить пеленкой (если пеленаете ножки). Но все же лучше, если на ней будет хотя бы одна пуговка.

Выходной комбинезон на кнопках в паху – позволяет легко сменить памперс, не раздевая малыша.

▶ Одежда ребенку от 3 до 6 месяцев

Рубашечки на пуговицах.

В холодное время – комбинезон-конверт (с рукавами, а внизу зашитый мешком). При покупке комбинезона ориентируйтесь не на длину рукава, а на длину штанин. Почему-то все комбинезоны (особенно теплые) шьются с чрезмерно длинными рукавами, и их приходится подворачивать.

▶ Одежда ребенку от 6 до 9 месяцев

Брючки с подшитыми штанинами. В сочетании с носочками они удобнее ползунков. Колготки под комбинезон (в холодное время года). Шапочки.

▶ Одежда ребенку от 9 до 12 месяцев

Рубашки, одевающиеся через голову, с застежкой спереди или на плече.

Джинсы на бретелях, или любые другие штаны из плотной ткани. Одежда должна легко стираться и быть плотной и желательно непромокаемой (особенно зимой и весной). Бретели играют больше декоративную роль, но могут и пригодиться, если ребенок решит некоторое расстояние проползти на коленях.

Раздельный комбинезон – штаны и куртка. Обувь для прогулок (полноценные сапожки или ботиночки, в которых можно ходить по земле, в том числе и мокрой. Предпочтительна обувь из натуральной кожи (нога не потеет) с широкой устойчивой подошвой, на небольшом каблучке). Дома лучше ходить босиком или в носках.



Выбирайте правильную обувь



● Первые ботиночки для малыша должны быть только из натуральных материалов. Это может быть кожа или плотная ткань. Ножка должна дышать.

● Первая обувь должна быть достаточно высокой - выше лодыжки. Она должна фиксировать голеностопный сустав почти неподвижно, чтобы ножка не болталась.

● На щиколотке обувь должна плотно фиксироваться застежкой, шнуровкой или липучкой.

● Задник должен быть обязательно жестким, чтобы пятка малыша не съезжала. При выборе нажмите на задник - вмятин остаться не должно.

● На детской обуви тоже нужен каблучок, но маленький - не больше 1,5 см.

● Желательно, чтобы пальчики были закрыты - ребенок часто спотыкается и может отбить их. Нос должен быть закругленным.

● Обычно в качественной детской обуви уже есть ортопедическая стелька-супинатор. Она поможет поддерживать свод и стопу в правильном положении.

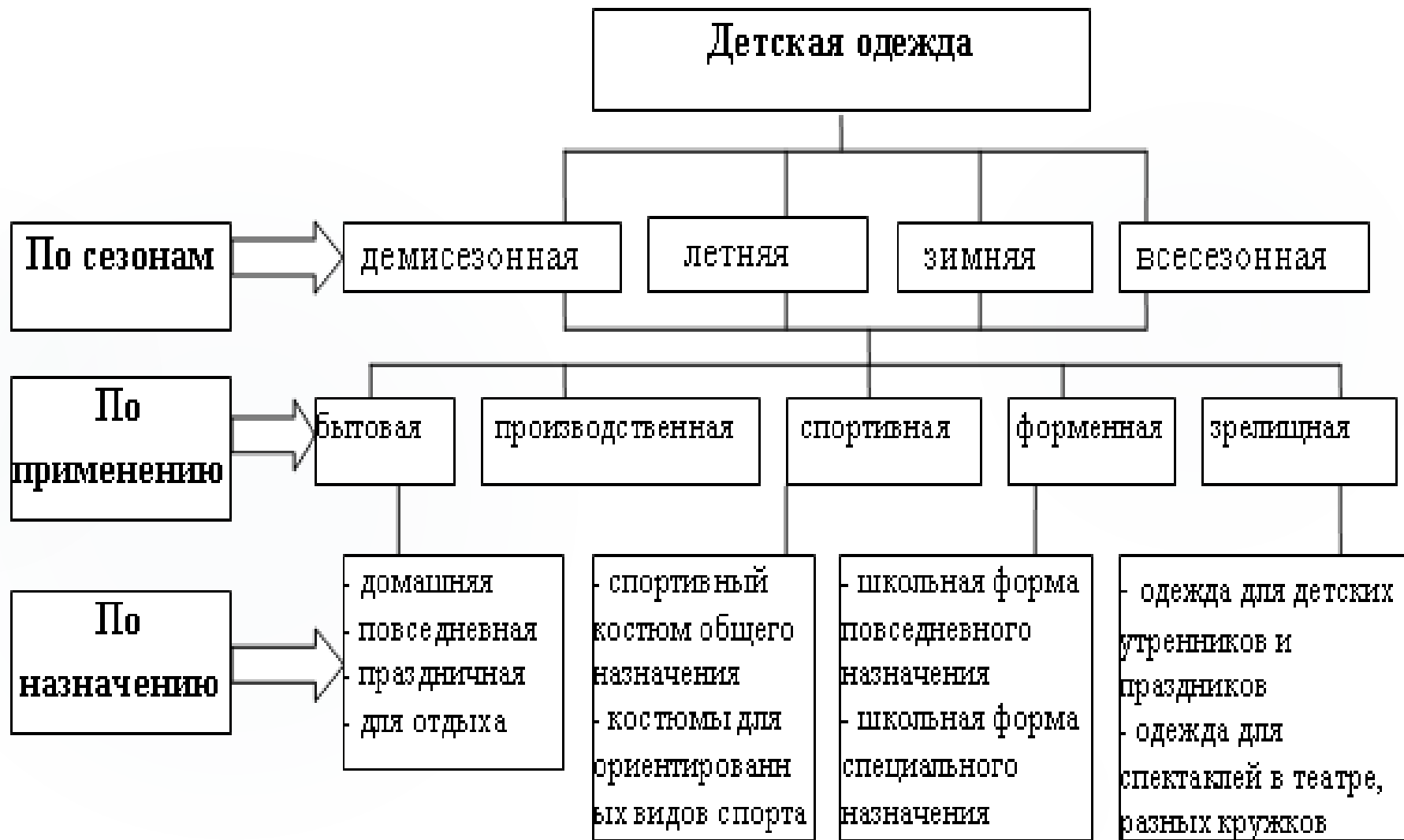
● Внутренний край детской обуви обязательно должен быть прямым, а не закругленным, как на некоторых взрослых вещах.



ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ПЛОСКОСТОПИЯ

- ваша обувь стоптана и изношена с внутренней стороны;
- ноги быстро утомляются при ходьбе и работе на ногах ;
- появляется усталость и боли в ногах к концу дня, судороги, чувство тяжести, отечность;
- отечность в области лодыжек;
- очень трудно ходить на каблуках;
- нога словно выросла - приходится покупать обувь на размер больше (особенно по ширине);
- стопа стала широкой настолько, что вы уже не влезаете в любимые туфли.

Ассортимент детских швейных изделий



Прогулки



- ▶ Начинают по рекомендации врача и проводить их желательно ежедневно.
- ▶ В зимний период года гулять с детьми можно при температуре воздуха не менее 10 градусов.
- ▶ Начинать с 15 – 20 минут, постепенно увеличивая время прогулки (необходимо ориентироваться на настроение ребенка).
- ▶ В летний период можно гулять с малышом сразу после выписки из стационара, лучше в лесопарковой зоне.
- ▶ Нельзя размещать ребенка под прямыми лучами солнца – это может привести к ожогу и перегреву его!
- ▶ Одежда для ребенка используется по сезону и по принципу: «Сколько слоев одето на маме – плюс один слой на ребенка».



Питание грудных детей

приоритет – грудное вскармливание



№ режима	Возраст (мес)	Число кормлений	Интервал ы между кормления ми (часы)	Часы	Ночной перерыв (часы)	Бодрствование (максимальная длительность в часах)
1а - свободное вскармливан ие	0-1	не менее 10		кормления по "требованию"		1-1,5
1	1-3	7	3	6-9-12-15- 18-21-24	6	1-1,5
2	1-5-6	6	3,5	6-9.30-13- 16.30-20- 23.30	6,5	1,5-2
3	5-6-9	5	4	6-10-14- 18-22	8	2-2,5
4	9-12	5	4	6-10-14- 18-22	8	2,5-3,5

Грудное молоко



- Адаптируется под малыша
- Изменяется в зависимости от климата, продолжительности и частоты вскармливания
- Адаптируется под пол малыша
- Развивает вкус малыша

Польза для малыша:

- Идеальный продукт
- Легко усваивается
- Укрепляет иммунную систему
- Защищает от болезней
- Развивает умственные способности

...и матери:

- Помогает прийти в форму
- Снижает риск возникновения рака груди и яичников, остеопороза
- Уникальная неразрывная эмоциональная связь с малышом



Почему грудное молоко – лучший выбор для ребёнка?



Грудное молоко легко усваивается организмом ребёнка

Состоит грудное молоко преимущественно из молочной сыворотки, которая легко переваривается в желудке ребёнка и содержит небольшое количество *белка* (0,9 – 1,1 гр. на 100мл.)

Грудное вскармливание улучшает умственное развитие ребёнка

Грудное молоко богато полиненасыщенными жирными кислотами с длинной цепью, такими как докозагексаеновая кислота, которая является компонентом серого вещества мозга и сетчатки глаза.

Грудное молоко усиливает природные защитные механизмы организма ребёнка

Мама делится своим иммунитетом в форме антител, содержащихся в грудном молоке. Защитными факторами являются содержащаяся в материнском молоке микрофлора представленная *бифидобактериями* и *лактобактериями* важные для развития здоровой флоры кишечника и иммунной системы.

Грудное молоко способствует защите ребёнка от заболеваний

Таких детских заболеваний, как желудочно-кишечные инфекции, воспаление среднего уха и респираторные инфекции. Материнское молоко защищает малыша от аллергии (прежде всего атопического дерматита). Осуществляет профилактику кардиометаболических заболеваний: ожирение, повышенное артериальное давление и диабет 2-го типа.

Позиция ВОЗ: содействие и поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях (2018)



1. Политика медицинских учреждений:
 - а. Соблюдать в полном объеме Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока и соответствующие резолюции ВОЗ.
 - б. Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении кормления детей грудного возраста и регулярно доводить ее до сведения медицинского персонала и родителей.
 - с. Создать системы постоянного мониторинга и управления данными.
2. Обеспечить, чтобы персонал обладал достаточными знаниями, компетенциями и навыками для того, чтобы надлежащим образом поддерживать грудное вскармливание.
3. Обсуждать с беременными женщинами и их семьями важное значение и технику грудного вскармливания.
4. Следует поощрять как можно более ранний и непрерывный контакт матери и ребенка «кожа к коже» после родов и помогать матерям начинать грудное вскармливание как можно раньше после родов.

Позиция ВОЗ: содействие и поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях (2018)



5. Матерям следует предоставлять практическую поддержку, чтобы они могли начать и продолжать грудное вскармливание и научились преодолевать обычные связанные с этим практические трудности.
6. Не давать новорожденным, получающим грудное вскармливание, никакого питания или питья кроме грудного молока, за исключением случаев медицинских показаний.
7. Давать матерям возможность оставаться вместе со своими грудными детьми и совместно пребывать в одной палате днем и ночью.
8. Матерям следует оказывать поддержку и обучать их распознавать сигналы и реакции их ребенка в том, что касается потребностей в кормлении, и реагировать на эти сигналы.
9. Консультировать матерей в отношении использования бутылочек и сосок для кормления, пустышек, а также связанных с этим рисков.
10. Обеспечить координацию выписки с тем, чтобы родители и их дети своевременно получали доступ к постоянной поддержке и надлежащему уходу.

Показатели достаточного количества питания



▶ Объективный показатель достаточного количества получаемого малышом молока - гармоничный рост и развитие:

- ▶ равномерное, в соответствии с возрастными нормами, нарастание массы
- ▶ тела и роста, окружности груди,
- ▶ хорошее состояние кожи (она чистая, розовая, бархатистая),
- ▶ спокойный сон,
- ▶ высокая сопротивляемость инфекциям.

Тест на мокрые пеленки

Выделение концентрированной мочи - менее 6 раз в день, желтого цвета, с резким запахом.

Контрольное взвешивание



Контроль веса

Плохая прибавка в весе (менее 125 грамм в неделю, а так же если вес через две недели от рождения меньше, чем был при рождении)

Контрольные взвешивания



Определение объема молока, необходимого ребенку

Суточный объем питания составляет:

Если возраст ребенка

от 7 дней до 2 месяцев – $\frac{1}{5}$ от общей массы ребенка (600-900мл)

от 2 до 4 месяцев – $\frac{1}{6}$ от общей массы ребенка (800-1000мл)

от 4 до 6 месяцев – $\frac{1}{7}$ от общей массы ребенка (900-1000мл)

от 6 до 8 месяцев – $\frac{1}{8}$ от общей массы ребенка (1000-1100мл)

старше 8-9 месяцев и до конца 1-го года – 1000-1200 мл.



Чтобы определить, сколько молока малыш высасывает необходимо провести «контрольные взвешивания» 3-4 раза в день в течение 3-4 дней, посчитав примерный объем за сутки.

Однако, особенно при грудном вскармливании, могут быть значительные колебания объема питания. Главным критерием является достаточная прибавка веса

Правила стерилизации сосок и бутылочек в медицинских организациях



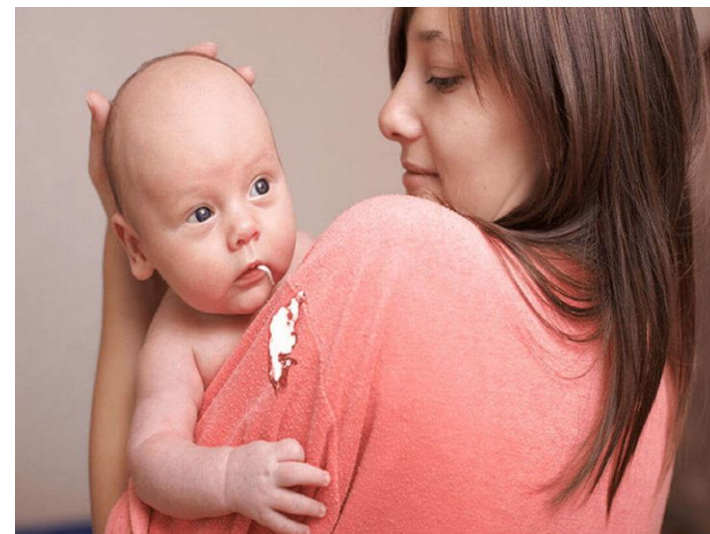
- ▶ Грязные соски тщательно моют сначала в проточной воде, а потом теплой водой с содой (0,5 чайной ложки пищевой соды на стакан воды), при этом их вывертывают наизнанку.
- ▶ Затем соски кипятят в течение 10–15 мин.
- ▶ Стерилизация сосок проводится раз в день, обычно в ночное время. Проводит ее палатная медицинская сестра.
- ▶ Чистые резиновые соски сохраняют сухими в закрытой (стеклянной или эмалированной) посуде с маркировкой «Чистые соски»
- ▶ Чистые соски достают стерильным пинцетом, а затем чисто вымытыми руками надевают на бутылочку. Использованные соски собирают в посуду с маркировкой "Грязные соски".
- ▶ Дома возможна стерилизация бутылочек и сосок путем кипячения в эмалированной кастрюле.



Срыгивания



- выделение небольшого количества съеденной пищи (молоко, смесь) сразу после кормления или в интервалах между ними.
- Срыгивания отличаются от рвоты тем, что при этом съеденная пища выделяется без усилий, без выраженных сокращений мускулатуры брюшной стенки.
- Общее состояние ребенка при этом не нарушается, выброс желудочного содержимого менее энергичен, ребенок как бы «сливает» молоко изо рта сразу или через небольшой промежуток после кормления.
- Срыгивания не сопровождаются вегетативными симптомами, не отражаются на поведении, аппетите, настроении ребенка.
- Причины: слабость кардиального сфинктера при хорошо развитом пилорическом, горизонтальное расположение желудка и форма его в виде «мешка», высокое давление в брюшной полости, горизонтальное положение самого ребенка и большой объем питания
- Появлению срыгиваний способствуют также резкая перемена положения детей вскоре после кормления, укачивание, тугое пеленание, крик, неосторожная пальпация живота, а также перекорм и аэрофагия.



Помощь при срыгивании и профилактика



- Выкладывание на животик на твердую поверхность перед кормлением;
- Правильное прикладывание к груди / соске рожка, профилактика аэрофагии;
- Постуральная терапия (выкладывание столбиком) до срыгивания (10 – 15 мин) под углом 45°;
- Не перекармливать ребенка (ИВ);
- Отсутствие тугого пеленания, стеснения живота ребенка;
- Маленькая дырка в соске рожка (при ИВ)



Кишечные колики



Правило троек:

Развиваются в течение первых 3 недель жизни

Длятся 3 часа в день и более

Повторяются не менее 3 раз в неделю

Продолжаются не менее 3 недель

Трудно успокоить

Красное лицо

Поджимает колени к груди

Громкий крик

Избыточное газообразование

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОЯВЛЕНИЮ КОЛИК У НОВОРОЖДЕННОГО

Нарушение
микрофлоры

Недоношенность

Недостаток
лактазы

Гипоксия

Несоблюдение
техники кормления

Ошибки при переходе
на искусственное
вскармливание

Неправильное
питание матери

Неблагоприятный
семейный климат

Нарушение
взаимосвязи между
матерью и ребенком



КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ ПРИ КОЛИКАХ



Погладьте животик
по часовой стрелке



Попробуйте
запеленать
ребенка не
туго



Положите
на животик
теплую
пеленку или
гелку.



Искупайте в теплой воде
с ромашковым отваром.



Понosite на руках,
прижав малыша
животиком
к своему животу.



Покачайте,
тихо спойте
колыбельную,
«пошикайте»



Включите
«белый
шум» или
успокаивающую
мелодию.



Положите кроху на фитбол
животиком и покачайте.



me

- Соблюдать правила кормления;
- Постуральная терапия;
- Выкладывать малыша на животик перед кормлением;
- Использовать бутылочки и соски, препятствующие заглатыванию воздуха;
- Скорректировать рацион питания мамы, если ребенок на грудном вскармливании;
- При необходимости подобрать подходящую молочную смесь и правильно ее готовить;
- Выкладывать ребенку на животик прогретую пеленку;
- Поглаживать и легко массажировать животик малыша;
- Купать младенца в теплой ванне;
- При необходимости применять ветрогонные лекарства, назначенные врачом (симетикон, фенхель, укроп).

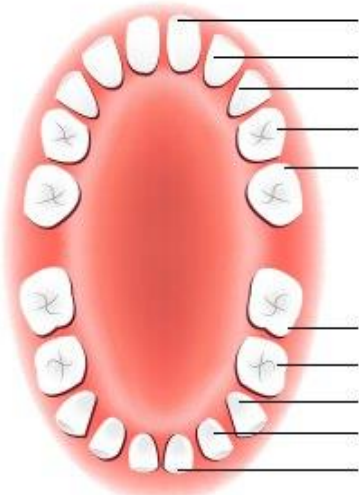
Зубы



- ▶ Как правило, первый зуб прорезывается у ребенка в 6 – 8 месяцев. С появлением первого зуба необходимо начать приучать к гигиене (чистке зубов) в игровой форме с помощью щетки с мягким ворсом.
- ▶ До этого времени для ухода за его полостью рта необходимо использовать салфетки или ватные диски.
- ▶ Для профилактики развития кандидоза (молочницы) один-два раза в неделю рекомендуется протирать полость рта ребенка салфеткой, смоченной слабым раствором бикарбоната натрия (пищевой соды).
- ▶ Появление зубов зачастую доставляет дискомфорт малышу и вызывает определенные изменения его поведения и состояния.

У современных детей все чаще можно наблюдать преждевременное или запоздалое прорезывание зубов.

Преждевременным или запоздалым прорезыванием считается отклонение от средних сроков на 2-3 месяца – для молочных зубов, а также 2-4 года – для постоянных зубов.

МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ		НАЗВАНИЕ ЗУБА	ВРЕМЯ ПРОРЕЗЫВАНИЯ	ВРЕМЯ ВЫПАДЕНИЯ	ТАК ВЫГЛЯДИТ
		Верхние зубы			
		Центральный резец	8 - 12 мес.	6 - 7 лет	
		Боковой резец	9 - 13 мес.	7 - 8 лет	
		Клык	16 - 22 мес.	10 - 12 лет	
		Первый моляр	13 - 19 мес.	9 - 11 лет	
		Второй моляр	25 - 33 мес.	10 - 12 лет	
		Нижние зубы			
		Второй моляр	23 - 31 мес.	10 - 12 лет	
		Первый моляр	14 - 18 мес.	9 - 11 лет	
		Клык	17 - 23 мес.	9 - 12 лет	
		Боковой резец	10 - 16 мес.	7 - 8 лет	
		Центральный резец	6 - 10 мес.	6 - 7 лет	

Использование сосок-пустышек



Соска – любой имитирующий сосок предмет, предназначенный для удовлетворения сосательного рефлекса.



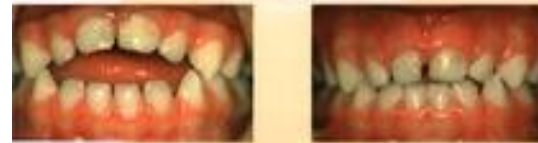
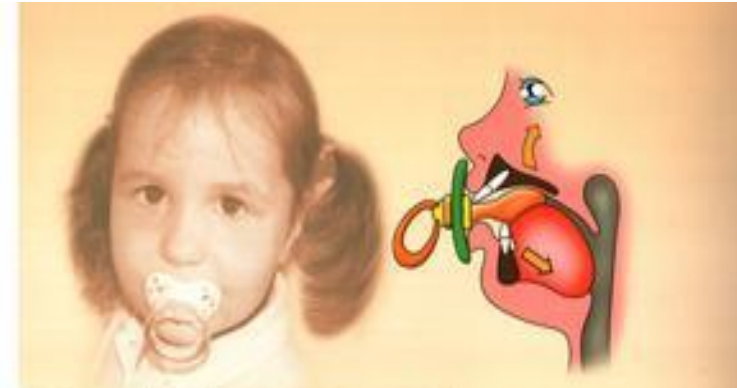
Сосательный рефлекс влияет на:

- на развитие и правильное совмещение костей черепа (если малыш сосет ритмично, правильно, кости черепа, сместившиеся во время родов, постепенно становятся на место и правильно срастаются);
- на эмоциональное развитие (при сосании раздражается твердое небо, которое связано с отделом мозга, отвечающим за эмоциональную сферу);
- на развитие интеллекта (при сосании стимулируется мягкое небо, связанное с гипофизом, отделом мозга, который вырабатывает гормоны, влияющие на рост и интеллект);
- отвечает за контроль движений головы, развитие мышц шеи, стимулирует развитие зрения.

Значение соски



- ❑ Соска удовлетворяет главный рефлекс малыша сосание.
- ❑ По мнению ученых, соска в психологическом плане неплохо заменяет мамину грудь.
- ❑ Соска нужна на зимней прогулке, ведь во время сна малыши приоткрывают ротик, и холодный воздух может стать причиной простуды.
- ❑ По мнению некоторых ученых, соска уменьшает риск внезапной смерти.
- ❑ Использование соски может стать причиной нарушения прикуса у ребенка.
- ❑ Использование соски облегчает путь для инфекций.
- ❑ При грудном вскармливании лучше почаще давать ребенку для успокоения грудь, а не пустышку.



Использование пустышек



- ▶ Не более 10 – 15 минут (для удовлетворения сосательного рефлекса (после еды) и успокоения (перед сном, после переодевания, после ушибов, падений).
- Пустышка должна быть чистой.
- Необходим запас сосок, особенно во время прогулок.
- Никогда не облизывайте пустышку перед тем как дать ее ребенку.
- С осторожностью используйте приспособления для прикрепления пустышки к одежде (длинные шнурки могут задушить ребенка).
- Если во время сна ребенок потерял пустышку и не плачет, не вставляйте ее обратно ему в рот.
- Пробуйте использовать другие способы успокоения ребенка.



Купание



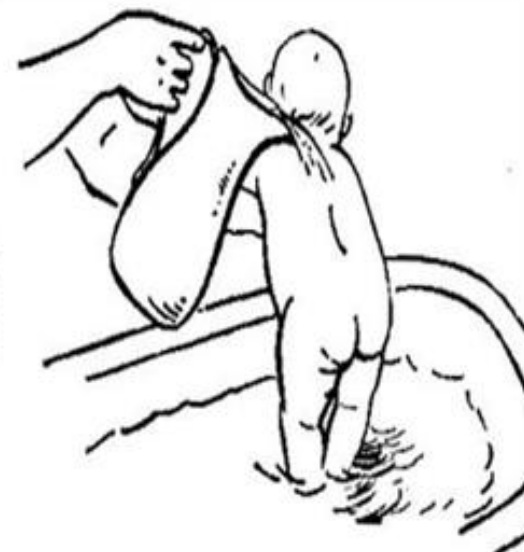
Этапы купания ребенка



Погружение ребенка
грудного возраста в ванну



Купание грудного ребенка



Обливание ребенка в
конце купания

Физическое и нервно-психическое развитие детей. Сон



**Сон ребенка в первые месяцы прерывается
потребностью питания, затем, по мере
созревания центральной нервной системы,
ребенок все больше бодрствует**



Возраст для доношенных детей	Всего сна в сутки, часов	Ночью	Днем	Кол-во дневных снов
1 мес.	15-18	8-10	6-9	3-4 и >
2 мес.	15-17	8-10	6-7	3-4
3 мес.	14-16	9-11	5	3/4
4-5 мес.	15	10	4-5	3
6-8 мес.	14,5	11	3,5	2-3
9-12 мес.	13,5-14	11	2-3,5	2

Физическое и нервно-психическое развитие детей



- ▶ Кора головного мозга по строению похожа на кору взрослого к 8 годам.
- ▶ Отмечается незрелость центров продолговатого мозга: дыхательного (апноэ), сердечно-сосудистого (аритмии), терморегуляции (поддержание постоянной температуры тела).
- ▶ Наиболее функционально развитым к моменту рождения является спинной мозг, он у новорожденного относительно более длинный.
- ▶ К моменту рождения у ребенка хорошо развиты осязание (особенно много тактильных рецепторов в коже лица, пальцев), вкус. Наименее зрелые – зрение и слух.

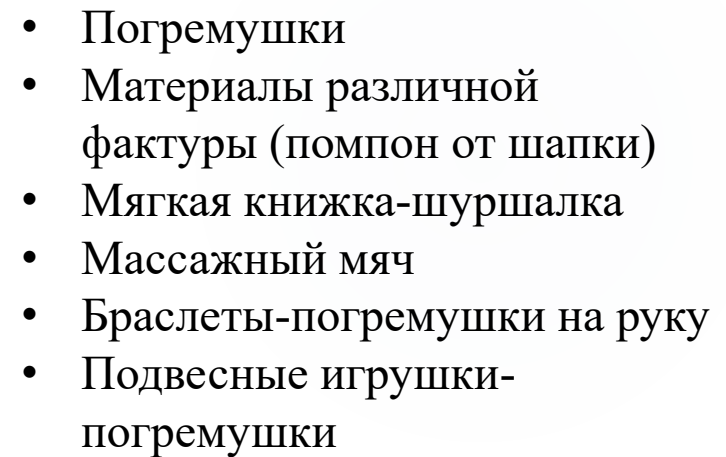


Нервно-психическое развитие детей



- ▶ Нервно-психическое развитие каждого ребенка – индивидуальный процесс, зависящий от многих факторов:
 - состояние здоровья,
 - темперамента,
 - наличие соответствующих возрасту игрушек,
 - постоянного общения.
- ▶ Поэтому сроки появления тех или иных показателей приблизительны.
- ▶ Постепенно совершенствуются двигательные умения, речевое развитие, активно развивается эмоциональная сфера.





Игрушки по месяцам

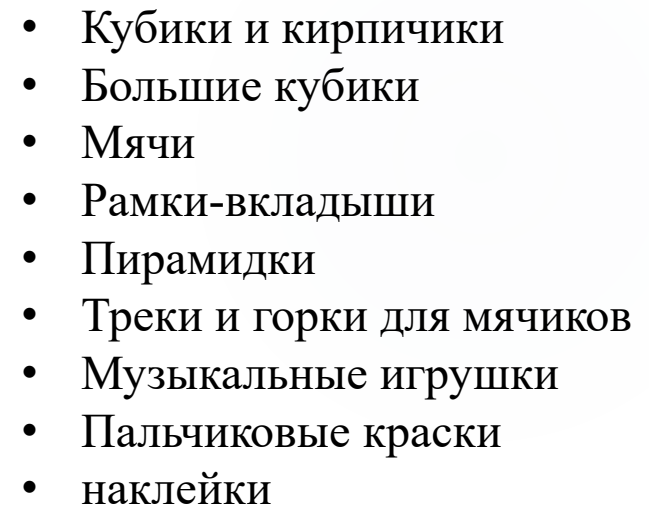


- Погремушки
- Подвесные игрушки-погремушки
- Прорезыватели (зубов)
- Мячи
- Материалы различной фактуры (помпон от шапки)
- Игрушки для ползания и переворотов
- Книжки детские с большими картинками

Игрушки по месяцам



- Мячи и шары
- Невалюшка
- Детская посуда
- Деревянные ложки
- Игрушечные молотки
- Ведерки
- Стаканчики-вкладыши
- Игрушки – животные
- Пирамидки
- Кубики
- Лабиринты с бусами
- Первые книжки



Показатели нервно-психического развития 1 – 6 месяцы



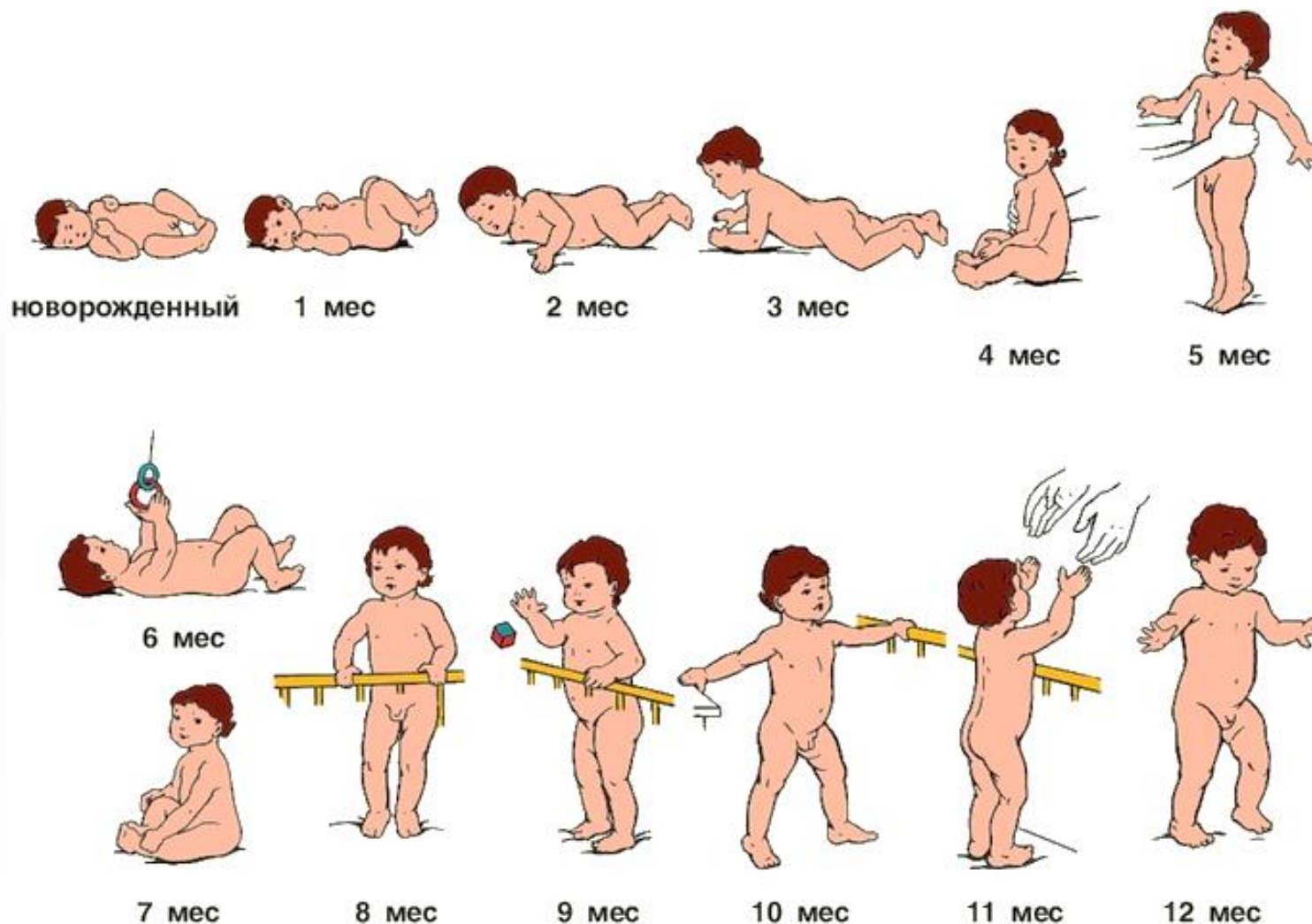
Возраст	Моторика	Речь	Эмоции	Органы чувств
1 месяц	Пытается удержать головку		4-5 недель – первая улыбка	Пытается фиксировать взгляд. Прислушивается.
2 месяца	Уверенно удерживает головку	Гуление	Улыбается знакомым лицам	Разглядывает игрушки, людей.
3 месяца	Держит головку, опираясь на предплечья (поза «сфинкса»)	Певучее гуление	Комплекс оживления	Следит за перемещением игрушки, пытается её ухватить.
4 – 5 месяцев	Поворачивается на бочок, спину, животик	Певучее гуление	Комплекс оживления	Захватывает и удерживает игрушки (ладонный захват)
6 месяцев	Сидит	Лепет	Отличает близких от незнакомых людей	Различные манипуляции с игрушками.

Показатели нервно-психического развития 7 – 12 месяцы



Возраст	Моторика	Речь	Эмоции	Органы чувств
7 – 8 месяцев	Ползает	Первые слова	Отличает близких от незнакомых людей	Различные манипуляции с игрушками
9 – 11 месяцев	Стоит с опорой, ходит с поддержкой.	Слова – обозначения («ава» – собака)	Играет в примитивные игры («ладушки»), может показать где у игрушки глазки, ротик, носик	Играет с игрушками – животными, машинками, кубиками, пирамидками, рассматривает картинки.
12 месяцев	Самостоятельно ходит	Говорит 10 - 12 слов («мама», «папа», «баба», «ляля» и т.д.)	Активно общается и выражает самые разнообразные эмоции.	Играет с игрушками – животными, машинками, кубиками, пирамидками, рассматривает картинки.

Динамика моторного развития на 1 году жизни – движения общие

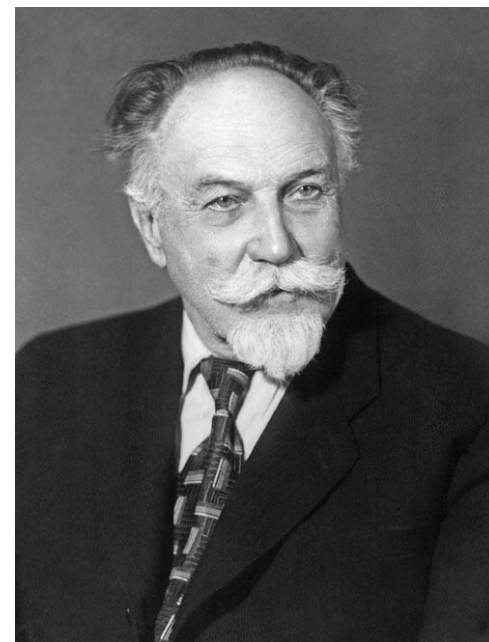


Физическое воспитание на 1-ом году жизни



Правила закаливания по Г. Н. Сперанскому:

1. Закаливание можно начинать и далее проводить только при полном здоровье ребенка.
2. Необходимо постепенное наращивание интенсивности закаливающих процедур.
3. Закаливание должно осуществляться систематически.
4. Закаливание необходимо проводить с учетом индивидуальных особенностей и возраста ребенка.
5. Начинать процедуры закаливания можно в любое время года, но лучше – в теплое.
6. Закаливание должно осуществляться только при положительных эмоциональных реакциях ребенка.
7. Если закаливание прерывается по причине болезни, то начинать его снова надо с первоначальных уровней интенсивности, но скорость наращивания закаливающих процедур должна быть большей, чем до перерыва.



Георгий Несторович
Сперанский
1873 – 1969

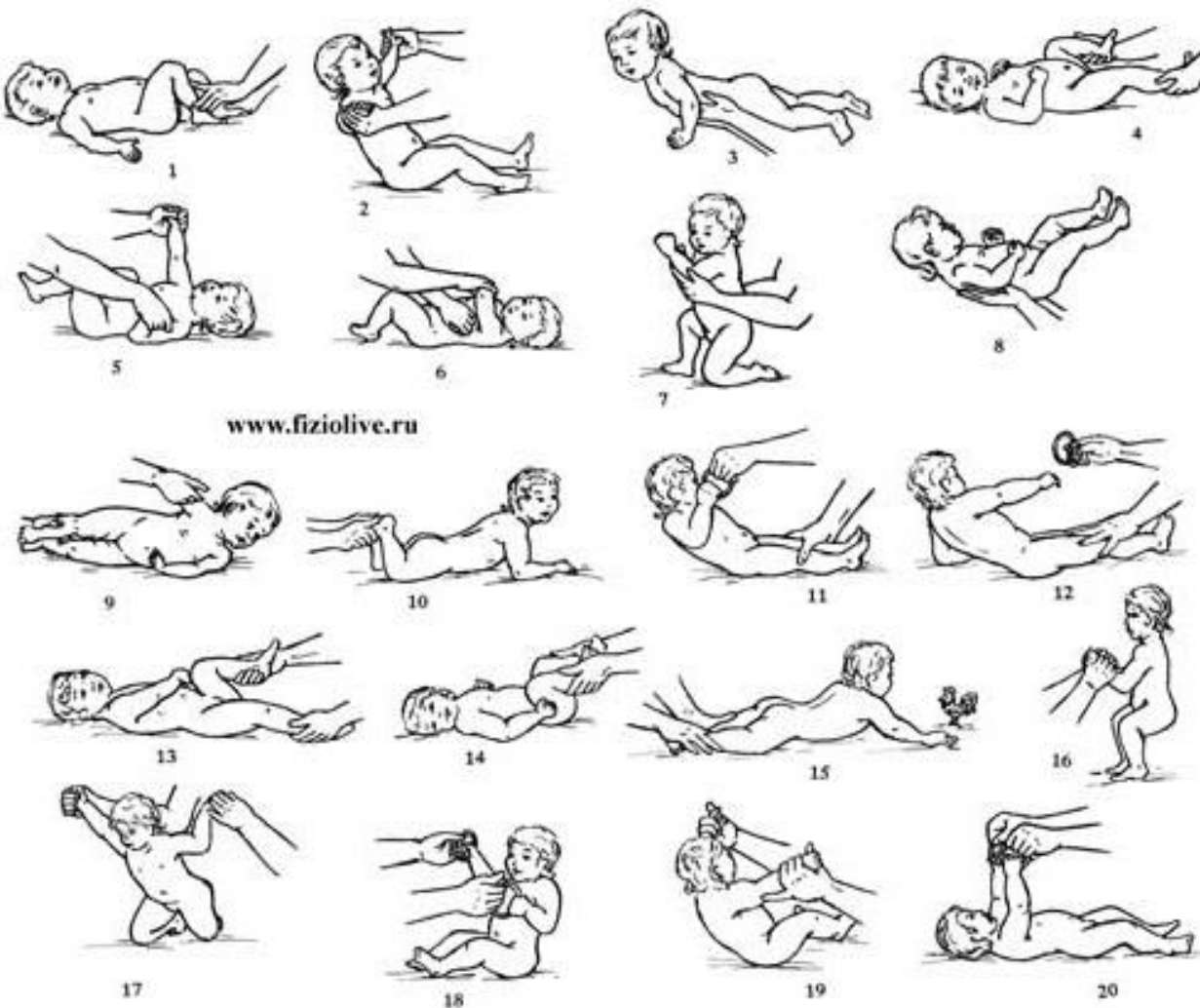
Организация режима дня детей до 1 года



- ▶ **Режим дня ребенка от рождения до 2,5-3 месяцев:** кормления 6–8 раз в сутки с интервалом между кормлениями в 3-3,5 часа (интервал может колебаться от 2,5 до 4,5 часов при свободном вскармливании). Бодрствование между кормлениями составляет при этом режиме 1-1,5 часа. Спит ребенок 4 раза в день по 1,5-2 часа.
- ▶ **Режим дня ребенка от 3 месяцев до 5-6 месяцев:** кормления 6 раз в сутки с интервалом между кормлениями в 3,5 часа и обязательным 10–11-часовым ночным перерывом. Режим дня ребенка в 3 месяца, в 4 месяца и в 5-6 месяцев обязательно включает сон 4 раза в день. Бодрствует ребенок по 1,5–2,0 часа. По режиму дня для 3-6 месячных детей могут жить и дети до 3 месяцев, если они хорошо едят и выдерживают промежуток между кормлениями в 3,5 часа.
- ▶ **Режим дня ребенка от 5-6 месяцев до 9-10 месяцев:** кормления 5 раз в сутки с интервалом между кормлениями 4 часа. Время бодрствования увеличивается до 2,0-2,5 часов, дневной сон – 3 раза в день по 2,0 часа, ночной – 10-11 часов.
- ▶ **Режим дня ребенка от 9-10 месяцев до 1 года:** Число кормлений – 5, интервал между кормлениями составляет 4–4,5 часа. Время бодрствования 3-3,5 часа, дневной сон – 2 раза в день по 2,0-2,5 часа, ночной – 10-11 часов.



Физическое воспитание ребенка – гигиеническая гимнастика, закаливание



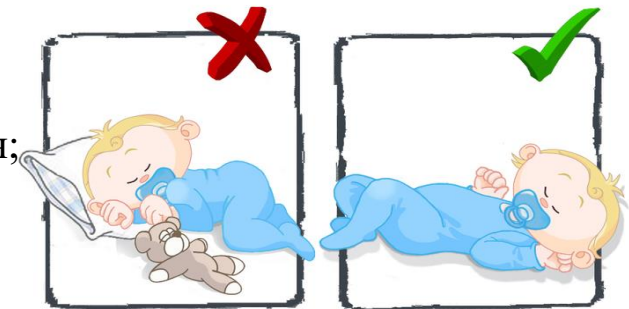
Синдром внезапной детской смерти (СВДС)



- ▶ внезапная смерть ребенка в возрасте от **7 дней до одного года жизни**, которая **остается необъяснимой после проведения полного посмертного исследования**, включающего вскрытие, исследование места смерти и анализ медицинской документации.

Факторы риска:

- пассивное курение ребенка;
- курение и прием алкоголя у беременных и кормящих женщин;
- недоношенность;
- многоплодная беременность;
- сон на животе;
- мужской пол ребенка;
- зимние месяцы года;
- ночное апноэ на первой неделе жизни (длительностью более 9–12 с);
- перегрев или переохлаждение ребенка;
- искусственное вскармливание ребенка;
- мягкие, старые матрасы в кроватке;
- наличие игрушек в кроватке;
- прием ребенком лекарственных средств;
- родственники с ночным апноэ в анамнезе и т. д.



Группы риска СВДС



Признаки риска	Баллы		
	0	1	2
Роды	Мать <21 года и/или масса тела <1500 г	Родов >2 и/или масса тела 2500 г	1 или 2 роды и масса тела >2500 г
Положение ребенка во сне	На животе	На боку	На спине
Постельные принадлежности	Мягкий матрац и/или тяжелая перьевая пери-на	Подушки и/или овчина	Кровать зарешечен-ная и спальный ме-шок
Курение матери	>10 сигарет в день	<10 сигарет в день	Не курящая
Продолжительность грудного вскармли-вания	<2 недель	<4 месяцев	>4 месяцев

Профилактика:

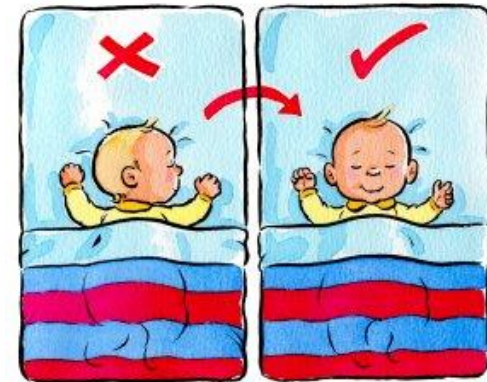
- ▶ Не выкладывать спать на животе;
- ▶ Не применять тугого пеленания;
- ▶ Не перегревать ребенка;
- ▶ Кровать в одной комнате с родителями;
- ▶ Естественное вскармливание;
- ▶ Позиционное постуральное положение;
- ▶ Избегать воздействия резких запахов, иных раздражителей;
- ▶ Пустышка во время сна (АА, 2005)?

При количестве баллов 0-3 риск СВДС составляет 1:100, при 10 баллах значи-тельно ниже 1:1000.

Меры по предупреждению СВДС (AAP, 2005)



- ▶ Шаг 1 – Сон на спине: положение ребенка во время сна - на спине
- ▶ Шаг 2 – Укладывать ребенка спать на твердую поверхность
- ▶ Шаг 3 - Убрать из детской кроватки мягкие предметы и незакрепленные постельные принадлежности
- ▶ Шаг 4 – Отказаться от курения во время беременности
- ▶ Шаг 5 – Спать на отдельной кровати, но в непосредственной близости от ребенка
- ▶ Шаг 6 – Придерживаться грудного вскармливания
- ▶ Шаг 7 – Избегать перегрева ребенка
- ▶ Шаг 8 – Поддерживать кампанию «Back to Sleep» («Сон на спине»)



СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ: КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА?





Особенности детей старше года. Организация ухода и воспитания

Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного периода (1-3 года)



В этот период отмечается постепенное совершенствование всех функциональных возможностей организма детей. Однако ребенок раннего возраста остается еще в высокой степени ранимым, восприимчивым к различным заболеваниям.

Особенности роста развития:

- темпы физического развития ребенка на 2-м и 3-м году жизни замедляются; за 2-й год рост увеличивается на 10 – 11 см, масса тела – на 2,5-3 кг, за 3-й год – соответственно на 7 - 8 см и 2 кг;
- Изменяются пропорции тела, относительно уменьшаются пропорция головы: с $\frac{1}{4}$ длины тела у новорожденного до $\frac{1}{5}$ у ребенка 3-х лет;
- происходит дальнейшее развитие речи, познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления), внимания;
- формируется костно-мышечная, эндокринная, пищеварительная и нервная системы;
- осваиваются новые навыки – ходьба, удержание тела в вертикальном положении, ориентация в пространстве, активация и совершенствование движения.

Особенности развития костно-мышечной системы



- К 2 годам (в 24 месяца) заканчивается формирование молочного прикуса – 20 молочных зубов (к 1 году – 8). С 5 лет начинается смена их на постоянные (в 6 лет – не менее одного постоянного зуба, в 7 лет – не менее четырех).
- Позвоночник до 1,5 лет растет равномерно, затем рост шейных и верхнегрудных позвонков замедляется, а с 5 лет рост позвоночника снова становится равномерным.
- В костях сохраняется еще много хрящевой ткани, что обеспечивает их гибкость и подвижность. Однако при этом несформировавшиеся кости, в том числе и позвоночник имеющий неустойчивые изгибы, легко искривляются и деформируются.
- Характерно также развитие мышечной системы, нарастание силы, ловкости и массы мышц (диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза). При этом отмечается преимущественное развитие крупных и средних мышц.
- Развитие же мелких мышц и, следовательно, мелкой моторики происходит гораздо медленнее и продолжается до 9-10 лет. Для стимуляции работы кисти детям рекомендуются специальные упражнения (мозаика, кубики, рисование, штриховка, лепка и т. д.).

Нервно-психическое развитие. Игры



- Начинают формироваться социальные связи. Для трехлетнего ребенка характерен эгоцентризм. Амбиции должны быть, из них вырастают личности. Они любознательны (почемучки).
- Особенно важны для этого возраста устранение гигиенических недочетов в воспитании и правильный режим в связи с повышенной чувствительностью ребенка к неблагоприятным влияниям окружающей среды.
- Для каждого возраста существует свой набор игрушек, игр-занятий.
- Примерный перечень игр-занятий для детей в возрасте 10- 12 мес: показ сюжетных игрушек (собаки, кошки и др.), игры-занятия с мячом, кубиками для развития движений, игры-развлечения типа «прятки», «ладушек», показ заводных игрушек.
- Примерный перечень игр-занятий для детей в возрасте 1 – 2 лет: занятия с картинками, «строительным» материалом в целях развития речи и координации движений. Даются задания различить предметы по их величине, форме.
- Примерный перечень игр-занятий для детей в возрасте 2 – 3 лет: беседы, читать книги, формировать у них первичные числовые представления, игры на внимание, развитие мелкой моторики пальцев рук, умение различать предметы и игрушки не только по величине и форме, но и по цвету.
- Примерный перечень игр-занятий для детей в возрасте 3 – 5 лет: игры для обучения элементарному счету, занятия рисованием, лепкой, аппликацией, музыкой, гимнастикой или физкультурой, подвижные и настольные игры.

Элементы игры нужны и для развития гигиенических навыков.

Игра должна также быть основой познавательной деятельности.

Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет



- ▶ Питание ребенка по общему столу (если нет заболевания, предписывающего индивидуальную диету)
- ▶ Расписание основных приемов пищи и закусок: 3 основных приема и пищи 2 закуски
- ▶ Предлагайте ребенку разнообразную свежую пищу (все основные группы продуктов)
- ▶ Придумывайте интересные варианты запахов, цвета и консистенции блюд и украшайте пищу, чтобы она была визуально привлекательной
- ▶ Учитывайте внутренние потребности детей в том, что касается чувства голода и насыщения
- ▶ Не предлагайте в рационе высококалорийные и малопитательные продукты
- ▶ Избегайте продуктов, которыми ребенок может подавиться
- ▶ Ограничьте потребление ребенком соков и других сладких напитков
- ▶ Отучите ребенка от бутылочки и начинайте кормить его с помощью чашки, ложки и тарелок; целесообразно 1-2 раза в день принимать пищу за одним столом со взрослыми, что способствует улучшению аппетита, приучает ребенка к определенным навыкам.
- ▶ Необходимо также обучать ребенка кушать аккуратно, пользоваться салфеткой, не отвлекаться во время еды.

Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет



- Белковая часть рациона должна обеспечиваться за счет мяса и рыбы. Дети в возрасте 1-3 лет могут получать говядину, телятину, мясо кур, кролика, нежирную свинину,, различные субпродукты (язык, печень, сердце), а также колбасные изделия (сосиски, сардельки, вареные колбасы, ветчины)
- Общее количество мясных продуктов – 80-100 г за день
- Рыбу (хек, треска, минтай, судак, лосось) можно давать и в отварном виде и в виде паровых котлет, тефтелей, биточков 1-2 раза в неделю
- Яйца (1/2 шт. в день) дают 2-3 раза в неделю, используя их также при приготовлении омлета, запеканок, салатов
- Из жиров рекомендуется сливочное масло (10-15 г в день) и различные растительные масла (5-6 г в день)
- В рационе должны быть овощи (морковь, свекла, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква и др.) и картофель (200 и 150 г, соответственно), фруктов (яблоки, груши, ягоды, бананы, апельсины) – до 130 г/день
- Крупы (гречневая, овсяная, рисовая, манная, кукурузная и др.) обязательно должны входить в рацион ребенка
- Количество сахара в рационе составляет 30-40 г, а сладостей – 20-30 г/день (мед, варенье, конфеты, печенье и др.).

Навыки личной гигиены



- ▶ Начинать высаживать ребенка на горшок необходимо сразу, как только ребенок уверенно научится сидеть.
- ▶ Уделяют внимание и гигиене физиологических отправления.
- ▶ К 1,5 годам ребенок должен уметь полоскать рот и чистить зубы. Вначале в течение 2-3 мес. зубы чистят влажной зубной щеткой, а затем с детской зубной пастой. Чистят зубы утром и вечером перед сном.
- ▶ В период с 1,5 до 2 лет ребенка следует научить самостоятельно пользоваться носовым платком.
- ▶ На 3-м году жизни необходимо приучать ребенка мыть руки перед едой, причем по собственному желанию, утром и вечером умываться, вытираться только своим полотенцем, салфеткой.
- ▶ Если ребенок воспитывается в коллективе, то личные вещи должны иметь маркировку: рисунки с изображением фруктов, овощей и т.д.



Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного периода (3-7 года)



Периоды:

- **младший** дошкольный возраст (3–4 года),
- **средний** (4–5 лет)
- **старший** (5–7 лет)

Данный период характеризуется интенсивным нервно-психическим развитием и изменением пропорций тела ребенка.

Происходит становление и развитие второй сигнальной системы – речи



Нервно-психическое развитие



Ребенок в возрасте 4 лет:

- группирует предметы по классам: классифицирует картинки и определяет среди них лишнюю; складывает из 3 частей разрезанные картинки; составляет рассказ по сюжетной картинке;
- из 4-5 показанных предметов вспоминает название 1-2 после того, как их убирает взрослый;
- застегивает пуговицы, молнию, зашнуровывает ботинки, срисовывает квадрат, после показа рисует человека из 3 частей; подпрыгивает на 2 ногах, продвигаясь вперед;
- умеет играть с детьми, не ссорясь и соблюдая правила игры; знает свои имя, фамилию, пол.

Ребенок в возрасте 5 лет:

- строит и составляет по образцу различные узоры (из кубиков, мозаики, конструктора); может составить из нескольких предложений рассказ по картинке с открытым и скрытым смыслом;
- запоминает последовательность разложенных на столе 4-5 картинок, находит одинаковые детали или предметы на 2 положенных рядом картинках; запоминает 1-2 четверостишия, скороговорки;
- сам одевается и раздевается; рисует человека из 3-6 частей; прыгает на 1 ноге;

Ребенок в возрасте 6 лет:

- ✓ понимает значения всех слов из бытовой лексики, называет, из чего сделаны отдельные предметы; составляет рассказ по 2-3 картинкам, связанным содержанием; отгадывает загадки;
- ✓ запоминает и рассказывает стихи и сказки; запоминает 6-8 слов и однозначных цифр;
- ✓ рисует человека из 6 частей, рисует круг; может аккуратно закрасить его карандашом; прыгает в длину с места не менее чем на 40 см;
- ✓ знает, как найти свой дом, что надо делать, если потеряет чужую игрушку, оценивает поступки и поведение окружающих; дает самооценку, знает имя и отчество родителей.

Адаптация к ДДУ



- 1. Острая фаза** – сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом состоянии, что приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц);
- 2. Подострая фаза** – характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится 3—5 месяцев);
- 3. Фаза компенсации** – характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития.

Эмоциональные
нарушения

Неврологические
нарушения:

Нарушения
физического
состояния

Поведенческие
нарушения

Степени адаптации



Легкая

- До 20 дней
- Настроение бодрое, в сочетании с утренним плачем, отношение с взрослыми не нарушено, отвлекаем, не наблюдается задержки нервно-психического развития, не болеет или болеет 1 раз

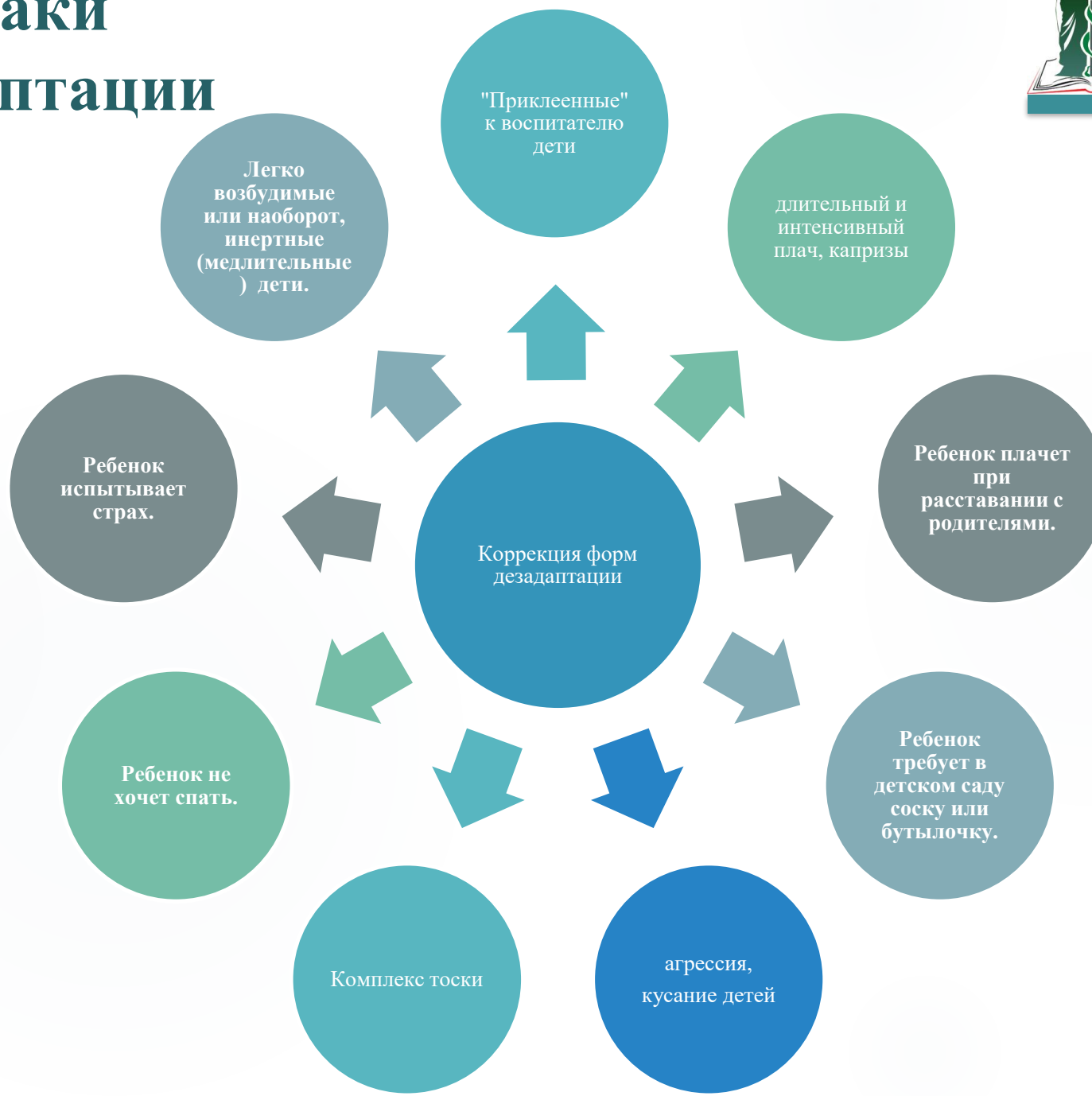
Средняя

- До 30 дней
- В течении месяца настроение неустойчивое, эмоционально-возбужденное, отношение к взрослым и детям избирательное. Некоторое снижение веса, заболевания до 2 раз, без осложнений

Тяжелая

- До 60 дней
- Проявление невротических реакций, плохой сон, нарушение аппетита, продолжительный длительный плач, плохая отвлекаемость, замкнутость или агрессия, страхи, неуправляемое поведение, истерические реакции, тремор, длительные заболевания

Признаки дезадаптации



Общие правила организации адаптационного периода



- ▶ Нужно учитывать потребность ребенка в еде, туалете, сне.
- ▶ Ко всему новому приучать постепенно.
- ▶ Единство и постоянство требований со стороны всех лиц, воспитывающих ребенка.
- ▶ Требования должны быть посильными.
- ▶ Создавать установку на все предстоящие режимные процессы.
- ▶ Все режимные процессы должны проводиться молча, без суеты., без причинения ребенку неприятных ощущений.
- ▶ Нельзя ребенка заставлять ждать предстоящий процесс.
- ▶ С первых дней приучать к активному участию в режимных процессах;
- ▶ Учитывать уровень развития культурно-гигиенических навыков ребенка.

Инструменты снижения риска дезадаптации



- ▶ Информирование ребенка об институте детского сада (новые друзья, новые знания и умения);
- ▶ Знакомство ребенка с местностью вокруг детского сада;
- ▶ Коррекция режима дня (приближение домашнего режима к режиму в детском саду – зарядка, приемы пищи (режим и диета), дневной сон ...);
- ▶ Формирование навыков самообслуживания и личной гигиены;
- ▶ Постепенное «вливание» в жизнь детского сада – посещение на 2-3 часа с постепенным увеличением до полного дня;
- ▶ Сохранение памяти о доме (любимая игрушка);
- ▶ Сдержанное прощание и радостная встреча

Подготовка к школе



Основная цель подготовки к обучению в школе:

- ▶ развитие эмоционально-волевой сферы;
 - ▶ развитие коммуникативных навыков;
 - ▶ формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей;
 - ▶ сохранение здоровья дошкольников.
-
- ▶ В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная деятельность.

Основными задачами подготовки к обучению являются:

- ▶ охрана и укрепление здоровья;
- ▶ развитие психических функций и качеств личности;
- ▶ обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе.

Готовность к обучению в школе



- ▶ К концу подготовительного периода у детей должна быть сформирована психологическая, физиологическая и социальная готовность к обучению в школе

Физиологическая готовность

- ▶ Выражается в уровне основных функциональных систем организма и состоянии здоровья детей. В основе критериев лежит способность ребенка переносить возросшие нагрузки, связанные с началом систематической учебной деятельности, интеллектуального и физического напряжения.

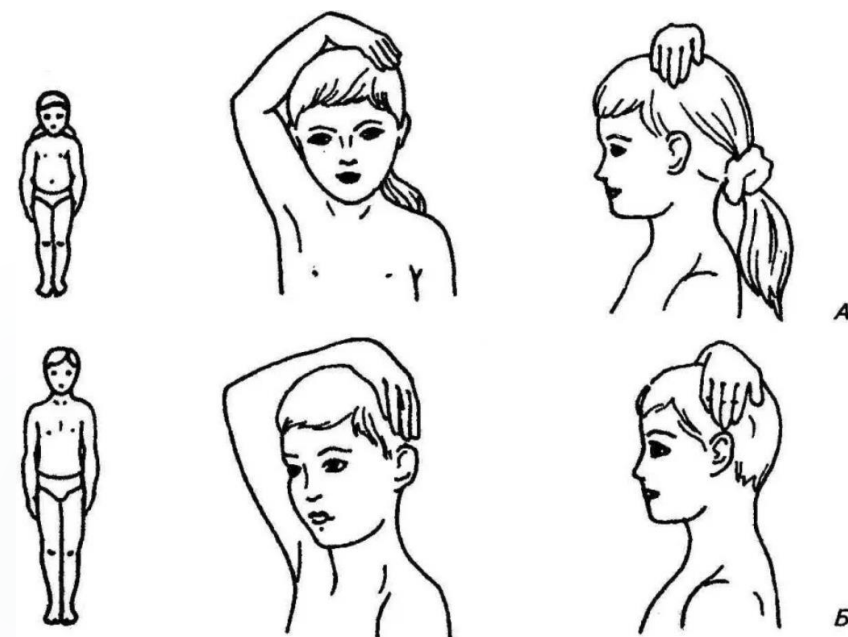
Социальная готовность

- ▶ Определяется готовностью ребенка к новым формам общения с окружающим миром. Развитие этой готовности связано с возрастным кризисом 6-7 лет. Ребенок при переходе от дошкольного к школьному возрасту резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении.

Психологическая готовность

- ▶ Определяется общим уровнем психического развития ребенка и уровнем развития важных в учебном плане качеств.

Тесты готовности к школе: Филиппинский, Керна-Йирасика, мотометрический тест Озерецкого



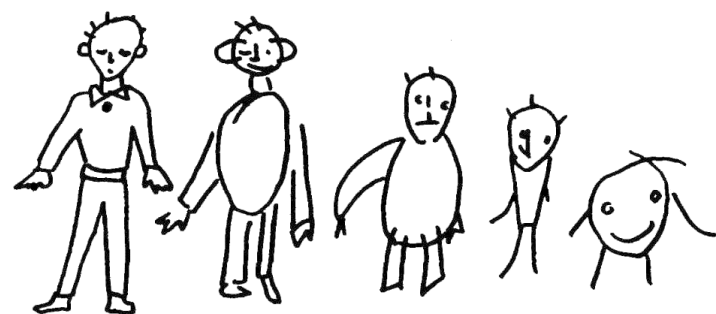
О н е л с у н
 О н е л с у н
 О н е л с у н
 О н е л с у н
 О н е л с у н

1 балл 3-6 баллов – высокий
 2 балла 7-12 баллов – средний
 3 балла 13-15 баллов – низкий
 4 балла уровень готовности к
 5 баллов школе;
 ребенок нуждается в
 дополнительном
 обследовании интеллекта и
 психического развития.

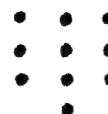
Вырезать за 60 сек

N – 80%

Не выходить за тусклые круги



Образец
задания



1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

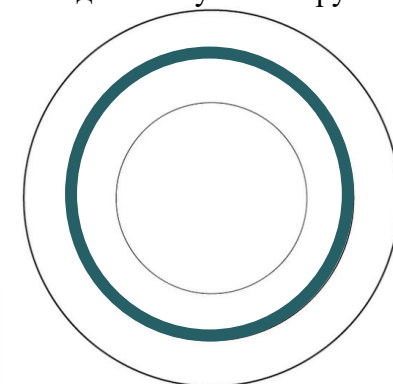
1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов



Критерии адаптации ребенка к школе



У первоклассников адаптация к школе оценивается по выраженности и продолжительности невротических реакций, появлению частых ОРЗ, обострению хронических заболеваний.

Благоприятная адаптация – отсутствие невротических реакций в течение 2 четвертей.

Среднеблагоприятная адаптация – умеренно выраженные невротические реакции на протяжении первых 3 четвертей учебного года (снижение работоспособности, высокая утомляемость, сниженная успеваемость, изменения в поведение ребенка – чрезмерное возбуждение, агрессивность, заторможенность, нежелание идти в школу).

Неблагоприятная адаптация – развитие неврозов у первоклассников (страхи, нарушения сна, аппетита, чрезмерная возбудимость или вялость).



Младший школьный возраст формирование учебной деятельности



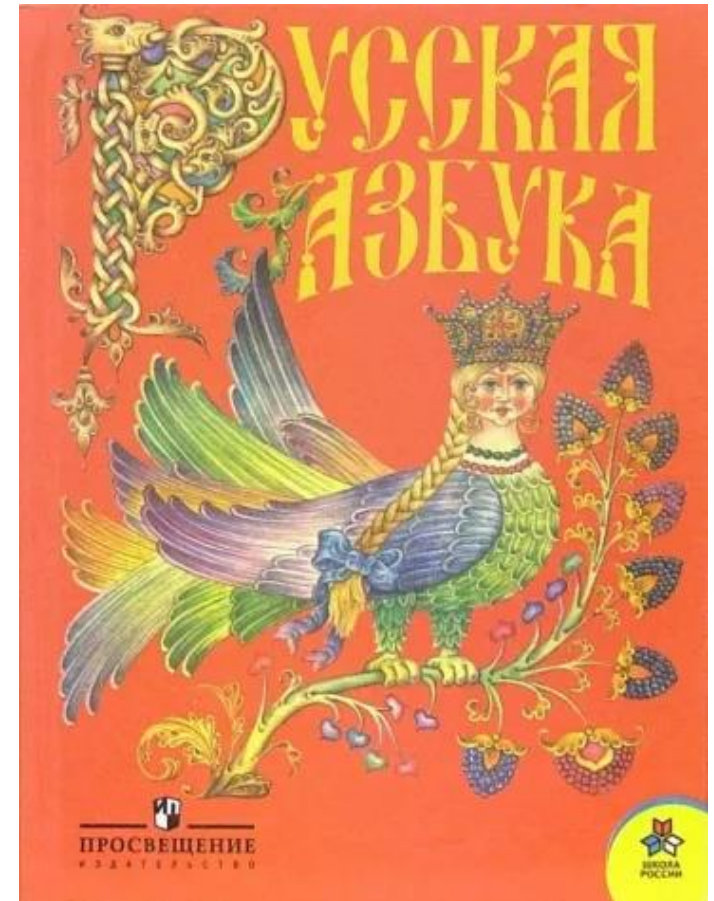
- ▶ Формируются изгибы позвоночника. У младших школьников крепнут мышцы и связки (растет их объем, увеличивается сила). Крупные мышцы развиваются раньше мелких.
- ▶ Интенсивно растет и хорошо снабжается кровью мышца сердца, увеличивается его выносливость.
- ▶ Благодаря сравнительно большому диаметру сонных артерий головной мозг хорошо снабжается кровью, что является важным условием его работоспособности.
- ▶ Наблюдается большее равновесие процессов возбуждения и торможения ЦНС.



Требования к обучению в первом классе



- ▶ Учебные занятия только в первую смену
- ▶ Пятидневная рабочая неделя
- ▶ Организация облегченного дня в середине учебной недели
- ▶ Проведение не более 4 уроков в день
- ▶ Продолжительность уроков не более 35 минут
- ▶ Обучение без балльной оценки знаний обучающихся, без домашних заданий
- ▶ Дополнительные каникулы в середине 3 четверти



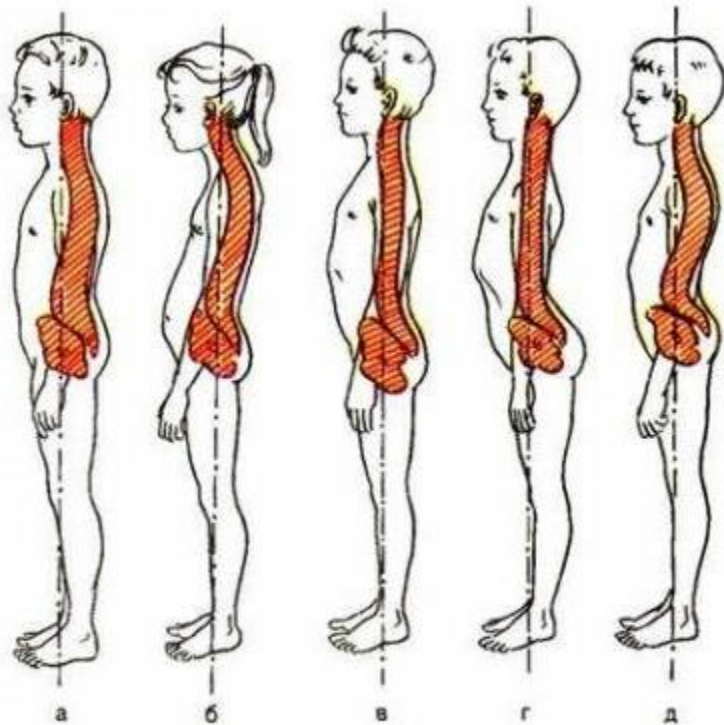
Анатомо-физиологические особенности подростков



- ▶ **Сердце.** Сердце интенсивно растет, сосуды часто отстают в развитии (особенно в периоды ростовых скачков) – эпизоды синкоп.
- ▶ **Кровеносные сосуды.** Рост кровеносных сосудов отстает от темпов роста сердца, поэтому повышается кровяное давление, нарушается ритм сердечной деятельности, быстро наступает утомление.
- ▶ **Скелет.** Значительно увеличиваются темпы роста скелета до 7-10 см, массы тела – до 4,5-9 кг в год.
- ▶ Активация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов, вызывающие интенсивное физическое и физиологическое развитие.
- ▶ «Гормональная буря» обуславливает трудности в функционировании сердца, легких, ЖКТ, головного мозга, перепады настроения, эмоциональную лабильность.



Профилактика «школьных заболеваний» у детей и подростков – нарушения осанки



Типы осанки: а — нормальная осанка; б — кифотическая осанка (круглая спина, сутулая спина); в — плоская спина; г — плосковогнутая спина; д — кифолордотическая осанка (кругловогнутая спина).

www.domsovetof.ru

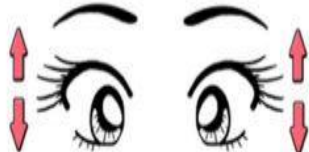
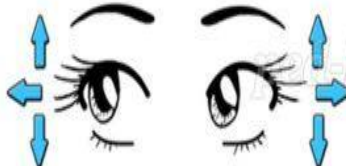
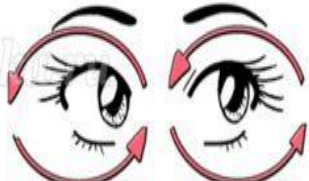
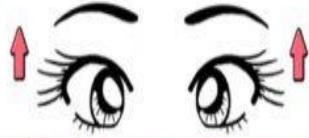
Признаки сколиоза



Профилактика «школьных заболеваний» у детей и подростков – нарушения зрения



Гимнастика для глаз

- 
1. Крепко зажмуриться пару секунд.
- 
2. Быстро моргаем минутку.
- 
3. Смотрим вверх, вниз, вправо, влево 2 раза.
- 
4. Вращаем по кругу туда и обратно.
- 
5. Закроем глаза. Темнота 3 секунды.
- 
6. Откроем глаза, начнём заниматься.

Игры и игрушки



3 – 6 лет

- Трицикл / велосипед / беговел
- Самокат, скейт
- Конструкторы
- Шнуровки и бусы для нанизывания
- Пазлы (10-20 деталей)
- Мягкие игрушки
- Куклы и одежда для кукол
- Одежда для переодевания
- Реквизит для сюжетно-ролевой игры
- Игрушки, на которых можно кататься
- Мячи-прыгуны
- Перчаточные куклы
- Нетоксичные материалы для творчества (ножницы, цветная бумага, мелки)
- Простые настольные игры
- Карточки на разные темы
- Головоломки

6 – 9 лет

- Велосипед и шлем
- Простое оборудование для плавания
- Коньки, ролики, скейт и защитное снаряжение
- Конструкторы
- Скакалка
- Фигурки
- Бумажная кукла с нарядами
- Книжки с наклейками
- Наборы для моделирования
- Настольный спорт
- Электронные игры
- Куклы, одежда и аксессуары
- Кукольные домики и мебель
- Настольные игры
- Головоломки
- Наборы для опытов и фокусов

9 – 12 лет

- Спортивное оборудование для улицы и защитное снаряжение
- Велосипед и шлем
- Сложные наборы конструкторов
- Пазлы / 3D пазлы
- Автомобили с дистанционным управлением
- Квадрокоптеры
- Моделирование
- Научные наборы
- Наборы для сложных фокусов, книги и карточки с оптическими иллюзиями
- Комплекты для творчества
- Стратегические настольные игры
- Настольный спорт
- Электронные игры

Подростки

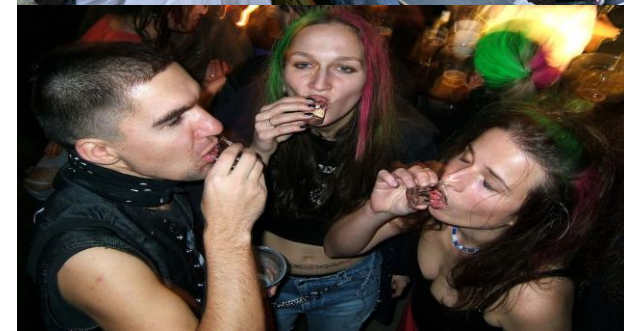


По определению ВОЗ, подростковый возраст является периодом роста и развития человека, который следует после детства и длится до достижения зрелого возраста, то есть с 10 до 19 лет. Это один из критических переходных периодов жизненного цикла.

Подростковый возраст – это время бурного роста и огромного потенциала, но, при этом, и время значительных рисков, когда мощное влияние оказывает социум.

Подростковый возраст – это период подготовки к зрелости, для которого характерен ряд ключевых аспектов развития:

- физическое и половое развитие,
- продвижение к социальной и экономической самостоятельности,
- развитие личности,
- приобретение навыков, необходимых для установления отношений и выполнения ролей в зрелом возрасте,
- формирование способности к абстрактному мышлению.



Половое развитие



- ✓ **У девушек:** под влиянием эстрогенов жировая клетчатка располагается по женскому типу, увеличиваются молочные железы, матка. Завершающаяся дифференцировка эндометрия и миометрия подготавливает организм к менструальной функции и деторождению. Андрогены надпочечников обуславливают появление и прогрессирование лобкового и подмышечного оволосения, acne vulgaris.
- ✓ Особого внимания заслуживает время наступления **менархе** (средний возраст наступления – 13 лет (от 9 до 15 лет)).
- ✓ **У мальчиков:** на фоне нарастания концентрации андрогенов, преимущественно тестикулярного происхождения формируются вторичные половые признаки, затем завершается сперматогенез. О последнем косвенно судят по времени появления первых эякуляций (**поллюции**).



Правила гигиены для детей старшего возраста



- ▶ Нательное белье должно быть на натуральных тканях
- ▶ Девочка должна подмываться 2 раза в день, а во время менструаций 3 – 4 раза в день. Мальчик должен подмываться 1 – 2 раза в день, открывать и обмывать головку полового члена.
- ▶ Девочка во время менструаций и в холодную погоду должна обязательно носить теплое нижнее белье.
- ▶ В дни менструации девочка должна менять прокладки 4 – 6 раз в день, в зависимости от объема кровотечения.
- ▶ У мальчиков нижнее белье должно быть не слишком свободным, но и не тесным; так как перегревание или травмирование яичек приводит к повреждению паренхимы и развитию мужского бесплодия.
- ▶ При появлении юношеских угрей необходимо обратиться к дерматологу, ни в коем случае их нельзя выдавливать.

